

سازمان شهدا – ولایت دایکندی

Shuhada Organization — Daikundi

کتاب قانون زبان

راهنمای جامع و عملی

Provincial Coordinator

در بخش صحت – با سناریوهای واقعی، تمرین و جواب مدل

پلان

نظارت

راپور

نسخه دوم – ویرایش شده، تصحیح شده و آماده نشر

۱۴۰۵ خورشیدی

«Working for a better tomorrow»

کتاب قانون زبان

راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

سازمان شهدا – ولایت دایکندی
Shuhada Organization – Daikundi
«Working for a better tomorrow»

نسخه دوم – ویرایش شده، تصحیح شده و آماده نشر

۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پیشگفتار

درباره این کتاب

چگونه از این کتاب استفاده کنیم

نقشه راه ده فصل

فهرست اختصارات

فصل اول: ذهن یک Provincial Coordinator چگونه کار می‌کند؟

۱.۱. وظایف واقعی یک Provincial Coordinator

۱.۲ Planning – پلان‌سازی

۱.۳ Work Plan – پلان کاری

۱.۴ نظارت (Monitoring) – چطور و چرا؟

۱.۵ شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

۱.۶ Risk و Issue – فرق‌شان چیست؟

۱.۷ Prioritization – کدام کار اول؟

۱.۸ Follow-up – پیگیری

۱.۹ چرخه کار Coordinator – از اول تا آخر

۱.۱۰ اشتباهات رایج یک Coordinator

۱.۱۱ تمرین کوتاه

۱.۱۲ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل دوم: راپورنویسی و ارتباطات حرفه‌ای

۲.۱ راپورنویسی (Reporting) – چرا این‌قدر مهم است؟

۲.۲ راپور روایتی (Narrative Report)

۲.۳ راپور ماهوار و ربعوار (Monthly/Quarterly Report)

۲.۴ خلاصه اجرایی (Executive Summary)

۲.۵ پلان اقدام (Action Plan)

۲.۶ چالش‌ها و درس‌های آموخته‌شده (Challenges & Lessons Learned)

۲.۷ راپور حادثه‌ای (Incident Report)

۲.۸ راپورنویسی – اشتباهات رایج

۲.۹. تمرین کوتاه

۲.۱۰. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل سوم: نظام صحتی افغانستان، HMIS، PPHD، MoPH و DHIS2

۳.۱. ساختار صحتی افغانستان

EPHS و BPHS ۳.۲

سیستم معلومات صحتی – HMIS ۳.۳

سیستم معلومات صحتی دیجیتالی – DHIS2 ۳.۴

و اسناد اصلی Register ۳.۵

۳.۶. تمرین کوتاه

۳.۷. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

۳.۸. نظام صحتی افغانستان امروز (۱۴۰۵) – چیزهایی که در کار روزمره می‌بینی

فصل چهارم: تدارکات، دوا، لوژستیک و دارایی‌ها

۴.۱. تدارکات (Procurement)

۴.۲. مصرف متوسط ماهانه (AMC)

۴.۳. موجودی (Stock) و Stock Card

۴.۴. نقطه سفارش مجدد (Reorder Point)

۴.۵. کمبود دوا (Stock-out) – چطور مدیریت کنیم؟

۴.۶. زمستانی‌سازی (Winterization)

۴.۷. مدیریت دارایی‌ها (Asset Management)

۴.۸. تمرین کوتاه

۴.۹. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل پنجم: مدیریت مالی

۵.۱. بودجه (Budget)

۵.۲. پلان‌شده در مقابل واقعی (Planned vs Actual)

۵.۳. تفاوت بودجه (Variance)

۵.۴. پیش‌پرداخت (Advance)

۵.۵. تصفیه پیش‌پرداخت (Advance Clearance)

۵.۶. اسناد حمایتی (Supporting Documents)

۵.۷. پول نقد (Cash) و مدیریت آن

۵.۸. حسابرسی (Audit)

۵.۹. تمرین کوتاه

۵.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل ششم: منابع بشری و اداره

۶.۱. استخدام (Recruitment)

۶.۲. شرح وظایف (ToR)

۶.۳. لیست کوتاه (Shortlisting)

۶.۴. مصاحبه (Interview)

۶.۵. حاضری (Attendance)

۶.۶. رخصتی (Leave)

۶.۷. ارزیابی عملکرد (Performance)

۶.۸. اجرایات (Disciplinary Process)

۶.۹. محرمانگی (Confidentiality)

۶.۱۰. حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی (PSEA)

۶.۱۱. تمرین کوتاه

۶.۱۲. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل هفتم: هماهنگی و مدیریت Stakeholderها

۷.۱ Stakeholder؟ ها کی‌ها اند؟

۷.۲. هماهنگی با PPHD

۷.۳. هماهنگی با MoPH

۷.۴. هماهنگی با دفتر مرکزی

۷.۵. هماهنگی با جامعه

۷.۶. مدیریت تعارض (Conflict)

۷.۷. ارتباط (Communication)

۷.۸. تشدید (Escalation)

۷.۹. تمرین کوتاه

۷.۱۰. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل هشتم: سناریوهای واقعی Provincial Coordinator

۸.۳۱. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل نهم: Shuhada Organization را بشناس

۹.۱. تاریخچه

۹.۲. مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

۹.۳ ساختار سازمانی

۹.۴ فعالیت‌های صحنی SO در دایکندی

۹.۵ فرهنگ سازمانی SO

۹.۶ مسئولیت‌های این بست (Provincial Coordinator)

۹.۷ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل دهم: شبیه‌سازی کامل امتحان و مصاحبه

آزمون آزمایشی ۱

آزمون آزمایشی ۲

آزمون آزمایشی ۳

۱۰.۱ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

پایان کتاب — پیام آخر

پیوست ۱: واژه‌نامه دری-انگلیسی

پیوست ۲: قالب‌های کاری و چک‌لیست‌ها

۲.۱ چک‌لیست نظارت از یک مرکز صحنی (Monitoring Visit)

۲.۲ قالب راپور ماهوار

۲.۳ قالب راپور حادثه‌ای (Incident Report)

۲.۴ کاربرد محاسبه AMC و Reorder Point

۲.۵ چک‌لیست تصفیه پیش‌پرداخت (Advance Clearance)

۲.۶ قالب پلان کاری ماهوار

۲.۷ قالب صورت‌جلسه کوتاه (Minutes)

پیوست ۳: پلان ۹۰ روزه اول کار

پیوست ۴: راهنمای امتحان و مصاحبه

پیوست ۵: منابع و مراجع

درباره این نسخه

پیشگفتار

می‌ایستد و باید کارها را به پیش ببرد: هماهنگ‌کننده ولایتی (Provincial Coordinator) در بخش صحت. برای کسی نوشته شده که در ولایت، میان دفتر مرکزی، ریاست صحت عامه ولایت (PPHD) و مراکز صحت این کتاب

تو بدهد، بلکه برای اینکه در آن لحظه بدانی اول چه کار کنی، بعد چه کار، و چطور همه‌اش را مستند کنی. ۱۲ جواب می‌خواهد. این کتاب برای همین لحظه‌ها نوشته شده است: نه برای اینکه «معلومات زیاد» به نفرستاده، قابله‌ای که استعفا داده، بودجه‌ای که تمام شده، جلسه‌ای که امروز است و سؤالی که تا ساعت که این کار را انجام می‌دهد، هر روز با چند نوع فشار روبه‌رو است: مریضی که دوا ندارد، کلینیکی که راپور کار Coordinator را نمی‌توان فقط با خواندن یک Job Description یاد گرفت. کسی

این نسخه چه چیزی دارد؟

مالی، منابع بشری، هماهنگی با Stakeholder ها و فرهنگ سازمانی Shuhada Organization می‌رسد.
 • ده فصل که از ذهن و روش کار Coordinator شروع می‌شود و به نظام صحتی، تدارکات، مدیریت
 • بخش دوم هر فصل: «تمرین کوتاه» با سناریو و جواب مدل - به زبان دری و انگلیسی.
 هشتم: سی سناریوی واقعی کار Coordinator، هر یک با خط اقدام و جواب انگلیسی برای مصاحبه.
 • فصل

• فصل دهم: سه آزمون آزمایشی کامل (چند گزینه‌ای، سؤال کوتاه، سناریو، محاسبه و راپورنویسی).
 همان روز در دفتر استفاده کنی، پلان ۹۰ روزه اول کار، راهنمای مصاحبه، و واژه‌نامه دری-انگلیسی.
 • پیوست‌ها: قالب‌های کاری که می‌توانی
 • یک اصل در تمام کتاب تکرار می‌شود: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن.

درباره صحت معلومات این نسخه

و معلومات صحت عامه سازمان جهانی صحت و شرکای صحت افغانستان. منابع در پیوست ۵ یاد شده‌اند. (BPHS) وزارت صحت عامه، رهنمای HMIS وزارت صحت عامه، اصول شش‌گانه IASC در مورد PSEA، ممکن بوده، با منابع معتبر مقایسه و تصحیح شده است - از جمله معیارهای بسته خدمات صحتی اساسی معلومات صحتی و اداری این کتاب، جایی که

یادآوری مهم: این کتاب یک راهنمای آموزشی و کاری می‌گوید که باید از PPHD یا دفتر مرکزی بپرسی. پالیسی سازمان خودت و رهنمای PPHD ولایت است. جایی که کتاب جواب قطعی ندارد، همان‌جا که به مریض، دوا یا درمان مربوط می‌شود، معیار نهایی همان رهنمای رسمی وزارت صحت عامه (MoPH)، است، نه سند پالیسی و نه پروتوکول درمانی. در هر موردی

درباره این کتاب

واقعی این بست، تجربه میدانی در ولایت دایکندی و ساختار رسمی نظام صحتی افغانستان تهیه شده است. هماهنگ‌کنندگان ولایتی (Provincial Coordinator) در بخش صحت است. محتوای آن بر اساس وظایف این کتاب یک راهنمای عملی و خودآموز برای

این کتاب برای کیست؟

۱. کسی که تازه به بست Provincial Coordinator گماشته شده و باید در چند هفته اول کار را راه بیندازد. سال Coordinator بوده، اما می‌خواهد روش کار خود را یکدست کند و راپور و پیگیری خود را قوی‌تر بسازد. کسی که چند

۳. کسی که برای امتحان و مصاحبه این بست آماده می‌شود.

صحتی، HMIS، تدارکات و مالی که با Coordinator کار می‌کنند و باید بدانند از آن‌ها چه انتظاری می‌رود. ۴. کارمندان

در این نسخه چه چیز اصلاح و اضافه شده است؟

جمعیتی مراکز صحتی (Health Post، BHC، CHC و شفاخانه‌ها) با معیار رسمی BPHS تصحیح شد. • معیارهای

وزارت صحت عامه، مهلت‌های راپوردهی HMIS و اصول PSEA با منابع معتبر مقایسه و اصلاح شد. • ساختار

افغانستان امروز (۱۴۰۵) - چطور خدمات اساسی تأمین می‌شود و این برای Coordinator چه معنی دارد. • بخش جدید ۳.۸ اضافه شد: نظام صحتی

• به شروع هر فصل یک بخش «اهداف این فصل» اضافه شد.

• پیوست‌های کاری (قالب‌ها، پلان ۹۰ روزه، راهنمای مصاحبه) و واژه‌نامه دری-انگلیسی اضافه شد.

ماهوار، ربعوار) در همه‌جا یکسان به کار رفته و نیم‌فاصله، نقطه‌گذاری و اعداد نظم گرفته است. • زبان کتاب یکدست‌سازی شد: اصطلاحات افغانی (مریض، شفاخانه، ولسوالی،

چگونه از این کتاب استفاده کنیم

۱. اگر وقت کم داری (۱۰ روز): را دوره کن و روز دهم یک آزمون آزمایشی فصل دهم را با وقت‌گیری حل کن. همان شب «تمرین کوتاه» و «جواب‌های طلایی» همان فصل را بازگو کن. روز نهم فصل هشتم (سناریوها) هر روز یک فصل بخوان و
 ۲. اگر برای کار روزمره می‌خوانی (۴ هفته): با یک کار عملی تمام کن: یک پلان کاری یا راپور واقعی بنویس. ۱ تا ۳؛ هفته دوم فصل‌های ۴ و ۵؛ هفته سوم فصل‌های ۶ و ۷؛ هفته چهارم فصل‌های ۸ تا ۱۰. هر فصل را هفته اول فصل‌های
 ۳. اگر برای مصاحبه آماده می‌شوی (۳ روز): هماهنگی؛ روز سوم فصل ۸ و یک آزمون آزمایشی فصل ۱۰. و ۹ (ذهن کار، راپورنویسی، شناخت سازمان)؛ روز دوم فصل‌های ۳ تا ۷ (نظام صحت، تدارکات، مالی، HR، روز اول فصل‌های ۱، ۲
- نشانه‌های کتاب

معنی	نشانه
جمله‌ای که در امتحان و مصاحبه بیشترین استفاده را دارد	★ برای امتحان
قاعده‌ای که باید از حفظ بدانی	● حفظ کن
اشتباه رایج و شکل درست آن	✓ / ✗
تعریف کوتاه و ساده مفهوم	مفهوم ساده
کاربرد همان مفهوم در وضعیت واقعی ولایت	مثال از دایکندی
جواب نمونه دری برای سناریوی تمرین	جواب مدل
همان جواب به انگلیسی – برای مصاحبه و امتحان نوشتاری	Sample Answer

نقشه راه ده فصل

فصل	موضوع	خروجی عملی برای تو	برای امتحان
۱	نظارت، KPI، اولویت‌بندی Coordinator: وظایف، پلان، ذهن یک	پلان کاری ماهوار نوشته‌شده یک	بسیار مهم
۲	رپور نویسی و ارتباطات حرفه‌ای	ماهوار و یک خلاصه اجرایی یک راپور	بسیار مهم
۳	DHIS2 و MoPH، PPHD، BPHS/EPHS، HMIS: صحتی: نظام	نظارت از ثبت معلومات یک چک‌لیست	بسیار مهم
۴	دوا، لوژستیک و دارایی‌ها تدارکات،	و Reorder Point مرکز خودت محاسبه AMC	مهم
۵	Variance، Advance، Audit مدیریت مالی: بودجه،	یک تصفیه پیش‌پرداخت کامل	مهم
۶	حاضری، اجراات، PSEA، منابع بشری و اداره: استخدام،	و یک پلان پیگیری حاضری یک ToR	مهم
۷	و مدیریت Stakeholderها همه‌نگی	ولایت خودت فهرست Stakeholderهای	متوسط
۸	سناریوی واقعی با جواب مدل سی	خط اقدام برای هر سناریو	بسیار مهم
۹	Shuhada Organization را بشناس	در باره مأموریت و ارزش‌ها جواب‌های آماده	مهم
۱۰	سه آزمون آزمایشی و مصاحبه	نمره آزمون خودت	تمرینی

فهرست اختصارات

در سراسر کتاب به کار رفته است. اگر اختصاری را کامل بگویید، امتیاز بیشتری می‌گیری.
این اختصارات

اختصار	به انگلیسی	به دری
ANC	Antenatal Care	مراقبت پیش از ولادت (معاینه زن باردار)
AMC	Average Monthly Consumption	مصرف متوسط ماهوار
BHC	Basic Health Center	مرکز صحتی اساسی
BPHS	Basic Package of Health Services	بسته خدمات صحتی اساسی
CHC	Comprehensive Health Center	مرکز صحتی جامع
CHW	Community Health Worker	کارمند صحتی جامعه (صحیار)
DH	District Hospital	شفاخانه ولسوالی
DHIS2	District Health Information Software 2	سیستم معلومات صحتی دیجیتالی
EPHS	Essential Package of Hospital Services	بسته خدمات اساسی شفاخانه‌ای
EPI	Expanded Program on Immunization	برنامه گسترده واکسیناسیون
HMIS	Health Management Information System	سیستم معلومات مدیریت صحتی
HP	Health Post	خانه صحتی (پست صحتی)
HR	Human Resources	منابع بشری
IASC	Inter-Agency Standing Committee	کمیته دایمی بین‌الوکاره‌ای
KPI	Key Performance Indicator	شاخص کلیدی عملکرد
MHT	Mobile Health Team	تیم صحتی سیار
MoPH	Ministry of Public Health	وزارت صحت عامه
NGO	Non-Governmental Organization	سازمان غیردولتی
OPD	Out-Patient Department	بخش سرپایی
PNC	Postnatal Care	مراقبت بعد از ولادت
PHC	Primary Health Care	خدمات صحتی اولیه
PPHCC	Provincial Public Health Coordination Committee	کمیته هماهنگی صحتی ولایت
PPHD	Provincial Public Health Directorate	ریاست صحت عامه ولایت
PSEA	Protection from Sexual Exploitation and Abuse	حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی
SHC	Sub Health Center	مرکز صحتی فرعی
SO	Shuhada Organization	سازمان شهدا

اختصار	به انگلیسی	به دری
TB	Tuberculosis	سل
ToR	Terms of Reference	شرح وظایف
UNICEF	United Nations Children's Fund	صندوق حمایت از اطفال ملل متحد
WHO	World Health Organization	سازمان جهانی صحت

بسم الله الرحمن الرحيم

راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

Shuhada Organization – Daikundi

شهدا سازمان – ولایت دایکندی

«Working for a better tomorrow»

درباره این کتاب

نمونه به زبان دری و انگلیسی می‌باشد. این نسخه، نسخه اصلاح‌شده، یکدست‌سازی‌شده و آماده نشر است. صحنه افغانستان تهیه شده و شامل ده فصل، سی سناریوی عملی، سه امتحان آزمایشی کامل و پاسخ‌های است. محتوای آن بر اساس وظایف واقعی این بست، تجربه میدانی در ولایت دایکندی و ساختار رسمی نظام یک راهنمای عملی و خودآموز برای هماهنگ‌کنندگان ولایتی (Provincial Coordinator) در بخش صحت این کتاب

نسخه اصلاح‌شده و آماده نشر

۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست مطالب

ذهن یک Provincial Coordinator چگونه کار می‌کند؟ فصل اول:

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. وظایف واقعی یک Provincial Coordinator را فهرست می‌کنی و می‌دانی کجا Coordinator است و کجا نه.
۲. می‌توانی یک پلان کاری واضح، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی شده بنویسی.
۳. تفاوت Monitoring و Risk، Evaluation و Issue، و اولویت‌بندی کارها را توضیح می‌دهی.
۴. چرخه هفت‌مرحله‌ای کار Coordinator را در یک وضعیت واقعی به کار می‌بری.

۱.۱ وظایف واقعی یک Provincial Coordinator

مفهوم ساده

در مرکز ولایت می‌نشینی، اما کارت در تمام ولسوالی‌ها، کلینیک‌ها و شفاخانه‌هاست Provincial Coordinator. یعنی «هماهنگ‌کننده ولایتی». تو

تو مدیر کل نیستی – تو حلقه وصل هستی:

- بین دفتر مرکزی (Central Office) و مراکز صحت ولایت
- بین ریاست صحت عامه ولایت (PPHD) و سازمان خودت
- بین کارمندان صحت، مالی، تدارکات و منابع بشری
- بین جامعه (مردم، قریه، شورای صحت) و خدمات صحت

رفاه و پیشرفت شهروندان افغان با تمرکز بر توانمندسازی زنان و اطفال است (Shuhada Organization (SO). پناهنده در کوئته، پاکستان بود. این سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقل است و هدف اصلی‌اش SO. در سال ۱۹۸۹ توسط داکتر سیما سمر بنیان گذاشته شد؛ اولین مرکز آن شفاخانه‌ای برای زنان و اطفال افغان اقتصادی زنان فعالیت دارد و در ولایات مرکزی افغانستان – از جمله دایکندی، بامیان و غزنی – کار می‌کند. در بخش‌های صحت، آموزش، حقوق بشر و توانمندسازی

ارزش‌های SO را حفظ کن

- حساسیت جنسیتی (Gender Sensitivity) • حرفه‌ای‌بودن (Professionalism) • تعالی (Excellence)
- شفافیت (Transparency) • پاسخگویی (Accountability)

وظایف عمده‌ای که در Job Description آمده است

وظیفه	یعنی چه؟
نظارت بر تطبیق پلان کاری	چک کردن اینکه کارها طبق پلان پیش می‌رود
هماهنگی با PPHD	رفتن به جلسات، شریک کردن راپور، پیگیری
نظارت (Monitoring) از مراکز صحت	رفتن به ساحه، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن
مدیریت راپور HMIS	جمع‌آوری، چک کردن و فرستادن معلومات صحت
پیگیری تدارکات و مالی	اطمینان از اینکه دوا، تجهیزات و پول به‌موقع می‌رسد
مدیریت منابع بشری	استخدام، حاضری، اجرايات، رفع مشکلات کارمندان
راپوردهی به دفتر مرکزی	راپور ماهوار، ربعوار، و در صورت ضرورت راپور حادثه‌ای

مثال از دایکندی

یک BHC (Basic Health Center) دوا تمام کرده. مسئول کلینیک تماس می‌گیرد. تو باید همزمان چند کار بکنی: فرض کن در ولسوالی شهرستان دایکندی

- پیگیری با تدارکات – دوا از کجا بیاید؟
- اطلاع دادن به PPHD – شاید از ذخیره ولایتی کمک شود
- چک کردن Stock Card – چرا دوا تمام شده؟ مصرف زیاد بوده یا تدارکات دیر رسیده؟
- راپور دادن به دفتر مرکزی – اگر مشکل بزرگ است، باید بدانند
- پیگیری تا رسیدن دوا – نه فقط یک بار تماس گرفتن

برای امتحان

نیست؛ مسئولیت پیگیری دارد. اگر فقط مشکل را شنید و اقدام نکرد، کار نکرده است Coordinator فقط «هماهنگ‌کننده»

پلان‌سازی – ۱.۲ Planning

مفهوم ساده

از اینکه کار شروع شود، بنویس که چه کار، کی، چطور، با کدام منبع و از کجا پول آن تأمین می‌شود Planning. یعنی: قبل

در محیط صحنی افغانستان، پلان‌سازی سه سطح دارد:

سطح	کی می‌سازد؟	مثال
پلان استراتژیک	دفتر مرکزی + MoPH	پلان پنج‌ساله BPBS
پلان سالانه	دفتر مرکزی + PPHD	پلان صحنی سالانه ولایت
پلان کاری ماهوار/ربعوار	تو – Coordinator	پلان نظارت، تدارکات، جلسات

مثال از دایکندی

پلان کاری ماهوار تو ممکن است این‌طور باشد:

هفته	فعالیت	مسئول	ساحه/وسیله	تاریخ
۱	نظارت از BHC نیلی	Coordinator	نیلی / موتر	هفته اول
۲	جلسه PHCC	Coordinator + PPHD	مرکز ولایت	هفته دوم
۳	چک کردن Stock	تدارکات	تمام مراکز	هفته سوم
۴	جمع‌آوری راپور HMIS	HMIS Officer	دفتر ولایتی / کمپیوتر	هفته چهارم

حفظ کن

هر پلان کاری باید ۵ چیز داشته باشد: چه کار؟ کی؟ کجا؟ با کدام منبع؟ چطور چک می‌شود؟

پلان کاری – Work Plan ۱.۳

مفهوم ساده

Work Plan، «می‌گوید» باید چه بشود Planning است. فرقی این است که Planning نسخه عملی Work Plan. «می‌گوید» چه کسی، کی، چطور انجام می‌دهد

:خوب این‌طور است Work Plan

- واضح: «نظارت از BHC» کافی نیست؛ بنویس «نظارت از BHC نیلی – چک کردن ۱۰ شاخص».
- قابل اندازه‌گیری: «بهبود کیفیت» کافی نیست؛ بنویس «افزایش استفاده از ANC از ۳۰٪ به ۵۰٪».
- مسئول مشخص: «تیم» کافی نیست؛ بنویس «مسئول HMIS ولایتی + Coordinator».
- زمان مشخص: «بعداً» کافی نیست؛ بنویس «تا ۱۵ ماه جاری».

مثال از دایکندی

اشتباهات رایج

۸۰ پلان ضعیف

«در ماه جاری از کلینیک‌های دایکندی نظارت می‌کنیم.»

اشتباهات رایج

۷۰ پلان قوی

مسئول: Coordinator + HMIS Officer. راپور نظارت تا ۳۰ ماه به PPHD و دفتر مرکزی فرستاده می‌شود. نظارت می‌کنیم. تمرکز نظارت روی ثبت صحیح معلومات HMIS، موجودی دوا و حاضری کارمندان است. «تا ۲۵ ماه جاری، از ۵ BHC در ولسوالی‌های نیلی، اشتی و شهرستان

۱.۴ نظارت (Monitoring) – چطور و چرا؟

مفهوم ساده

نظارت (Monitoring) ارزیابی Monitoring. یعنی رفتن، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن و پیگیری کردن Monitoring نیست.

	Monitoring	Evaluation
کی؟	در جریان کار	بعد از تمام شدن
چرا؟	آیا طبق پلان پیش می‌رویم؟	آیا به هدف رسیدیم؟
کی می‌کند؟	Coordinator، PPHD	تیم ارزیابی، داور
مثال	چک کردن Stock Card	بررسی کاهش مرگ‌ومیر مادران

مثال از دایکندی

تو به یک BHC در نیلی می‌روی. چه چک می‌کنی؟

- آیا ثبت‌ها کامل است؟ – Register
- آیا دوا موجود است؟ تاریخ انقضا چک شده؟ – Stock Card
- حاضری – آیا کارمندان حاضر اند؟
- راپور – آیا ماه گذشته راپور فرستاده شده؟ HMIS
- مریضان – چند مریض امروز آمده؟ آیا خدمات اساسی ارائه شده؟
- زمینه – آیا کلینیک تمیز است؟ تجهیزات کار می‌کند؟

برای امتحان

دیدن، باید به مسئول کلینیک بگویی و در راپور بنویسی. اگر نویسی، انگار نرفته‌ای Feedback بدون Monitoring فایده ندارد. اگر مشکل

Sample Answer

During a monitoring visit, I check the registers, stock cards, attendance, and HMIS reports. I compare reported data with source documents, identify gaps, discuss with the facility staff, provide on-the-job feedback, and document findings. I then follow up to ensure corrective actions are taken.

۱.۵ شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

مفهوم ساده

موفقیت را نشان می‌دهد. اگر نتوانی اندازه‌گیری، نمی‌توانی مدیریت کنی (KPI (Key Performance Indicator). یعنی معیاری که

KPI	یعنی چه؟	مثال از دایکندی
ANC Coverage	چند زن باردار برای معاینه آمده‌اند	۴۰۰ زن در ولسوالی نیلی
Skilled Birth Attendance	چند ولادت با داکتر/قابله انجام شده	۱۵۰ از ۲۰۰ ولادت
HMIS Reporting Rate	چند فیصد مراکز راپور فرستاده‌اند	۹۵٪ - یعنی ۵٪ دیر کرده
Drug Availability	چند فیصد دوا موجود است	۸۰٪ - ۲۰٪ کمبود
Stock-out Days	چند روز دوا نبوده	۵ روز - مشکل دارد

مثال از دایکندی

این یعنی ۳۰٪ کلینیک‌ها راپور نفرستاده‌اند. سؤال Coordinator فقط «چند فیصد؟» نیست؛ باید بپرسی: تو راپور می‌گیری: «HMIS Reporting Rate در ولایت ۷۰٪ است.»

- کدام کلینیک‌ها نفرستاده‌اند؟
- چرا؟ مشکل تخنیک؟ نبود کارمند؟ مشکل امنیتی؟
- چه اقدام فوری لازم است؟
- مسئول کیست؟ کی پیگیری می‌شود؟

حفظ کن

مقایسه و قابل اقدام باشد. اگر KPI فقط یک عدد باشد و اقدام نداشته باشد، آن KPI نیست - یک آمار است. هر KPI باید قابل اندازه‌گیری، قابل

۱.۶ Risk و Issue چیست؟

چیز؟	چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد	چیزی که قبلاً اتفاق افتاده
Risk (خطر)	Issue (مشکل)	

کی؟	آینده	حال
مثال	«ممکن است زمستان راه نیلی را ببندد»	«راه نیلی بسته است»
اقدام	پیشگیری	حل کردن

مثال از دایکندی

Issue	Risk
دوا در BHC شهرستان تمام شده	ممکن است دوا در زمستان دیر برسد
یک قابله در نیلی استعفا داده	ممکن است یک کارمند استعفا بدهد
راپور ماه گذشته فرستاده نشده	ممکن است راپور HMIS دیر شود

کار Coordinator:

• Risk ← پلان پیشگیری بساز (مثلاً: دوا را قبل از زمستان برسان)

• Issue ← فوراً حل کن، بعد راپور بده

Sample Answer

A risk is a potential future problem that may or may not happen. An issue is a problem that has already occurred. As a coordinator, I manage risks by planning mitigation measures in advance, and I manage issues by taking immediate corrective action, documenting it, and reporting to the relevant stakeholders.

کدام کار اول؟ – ۱.۷ Prioritization

مفهوم ساده

تو نمی‌توانی همه کارها را همزمان انجام بدهی. Prioritization یعنی انتخاب کردن مهم‌ترین کار.

اولویت	نوع کار	مثال
۱ – فوری	زندگی مردم در خطر	در کلینیک – جان مریض در خطر است نبود دوا
۲ – مهم	خدمات اساسی متوقف شود	نبود قابله – ولادت انجام نمی‌شود
۳ – ضروری	راپور و هماهنگی	راپور ماهوار دیر شود
۴ – معمولی	جلسات، فایلینگ	جلسه PHCC

مثال از دایکندی

یک روز صبح سه مشکل داری:

- در BHC نیلی دوا تمام شده – مریضان برمی‌گردند
 - راپور HMIS ماه گذشته هنوز فرستاده نشده – امروز آخرین روز است
 - جلسه هماهنگی با PPHD ساعت ۱۰ است
- به HMIS Officer بسپاری و خودت نظارت کنی. جلسه را هم می‌توانی با یک همکار بفرستی یا بعداً بروی. کدام اول؟ مشکل دوا – چون زندگی مردم در خطر است. راپور HMIS هم مهم است، اما می‌توانی

برای امتحان

همیشه این باشد: چک کن آیا زندگی کسی در خطر است یا خدمات اساسی متوقف شده. اگر بله، فوراً اقدام کن. در سناریو امتحان، اولین کارت

پیگیری – ۱.۸ Follow-up

مفهوم ساده

یعنی رها نکردن. مشکل را که شنیدی، حلش کن – بعد هم چک کن که واقعاً حل شده Follow-up. اشتراکی رفتی و دیدی Stock Card به‌روز نیست. به مسئول گفتی: «تا هفته آینده اصلاح کن.» Follow-up یعنی: تو به BHC

- هفته آینده تماس بگیری یا بروی
- چک کنی که اصلاح شده یا نه
- اگر نشده، بررسی چرا
- اگر باز هم نشد، به PPHD یا دفتر مرکزی اطلاع بدهی
- در راپور بنویسی که پیگیری انجام شده

حفظ کن

Document → Act → Verify → بررسی | Follow Up → اقدام ← مستندسازی ← در هر سناریو امتحان به کار ببر. پیگیری – این چهار کلمه را

۱.۹ چرخه کار Coordinator – از اول تا آخر

بفهم (Understand)

بررسی کن (Verify)

اولویت بده (Prioritize)

اقدام کن (Act)

مستند کن (Document)

راپور بده (Report)

پیگیری کن (Follow Up)

دوباره بررسی کن (Re-verify)

مثال کامل از دایکندی

می‌دهد که در BHC نیلی، تعداد مریضان TB صفر ثبت شده - در حالی که سال گذشته ۱۵ مریض بود. موقعیت: راپور HMIS نشان

بفهم: چرا صفر؟ آیا واقعاً مریض نیست، یا ثبت نمی‌شود؟

کن: به Register کلینیک مراجعه کن، با مسئول TB صحبت کن، بین آیا مریضان به جای دیگر می‌روند. بررسی

اولویت بده: اگر ثبت نمی‌شود، مریضان TB از خدمات محروم می‌شوند - این اولویت اول است.

اقدام کن: به مسئول کلینیک بگو ثبت را اصلاح کند؛ اگر لازم است آموزش کوتاه بده؛ به PPHD اطلاع بده.

مستند کن: در راپور نظارت بنویس - تاریخ، کلینیک، مشکل، اقدام، مسئول پیگیری.

راپور بده: راپور را به دفتر مرکزی و PPHD بفرست.

پیگیری کن: هفته بعد چک کن که ثبت TB درست شده یا نه.

Sample Answer

First, I would verify the data against the TB register at the facility. Then I would discuss with the TB focal point to understand whether there is a recording issue or if patients are seeking care elsewhere. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action is taken, document the findings, report to PPHD, and follow up to confirm the data is accurate in the next reporting period.

۱.۱۰ اشتباهات رایج یک Coordinator

اشتباهات رایج

۰۸ اشتباه ۱: فقط مشکل را شنیدن و کاری نکردن.

۰۷ درست: هر مشکل باید اقدام، مسئول و زمان پیگیری داشته باشد.

اشتباهات رایج

- ۴۰ اشتباه ۲: همه کارها را خودت انجام دادن.
- ۴۰ درست: Coordinator کار تیم را هماهنگ می‌کند، خودش همه کار نمی‌کند.

اشتباهات رایج

- ۴۰ اشتباه ۳: راپور را دیر فرستادن.
- ۴۰ درست: راپور به موقع = اعتماد PPHD و دفتر مرکزی.

اشتباهات رایج

- ۴۰ اشتباه ۴: قبول کردن معلومات بدون چک کردن.
- ۴۰ درست: همیشه با منبع اصلی (Register, Stock Card, حاضری) مقایسه کن.

اشتباهات رایج

- ۴۰ اشتباه ۵: در جلسه PPHD خاموش نشستن.
- ۴۰ درست: مشکل را واضح بگو، اقدام پیشنهاد کن، پیگیری بخواه.

۱.۱۱ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

سؤال مالی فوری دارد که باید تا ساعت ۱۲ جواب بدهی. سؤال: تو چه می‌کنی؟ به کدام اولویت می‌دهی؟ چرا؟ ناقص است - ۱۰ کلینیک راپور نفرستاده‌اند و امروز آخرین روز فرستادن به PPHD است. (۳) دفتر مرکزی یک Amoxicillin و Paracetamol تمام شده و ۲۰ مریض در صف است. (۲) HMIS Officer: راپور ماه گذشته ولایت تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. ساعت ۸ صبح سه خبر می‌رسد: (۱) BHC نیلی: دواى اساسى (مثلاً

جواب مدل

تا ساعت ۱۲ آماده می‌کنم و اگر نرسیدم، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم که تا چند ساعت دیگر می‌فرستم. می‌کنم که با ۱۰ کلینیک تماس بگیرد و راپور را جمع کند - خودم نظارت می‌کنم. جواب مالی را در وقت باقی‌مانده از PPHD کمک می‌خواهم و اگر ممکن باشد دوا را از مرکز نزدیک‌تر می‌فرستم. بعد HMIS Officer را مسئول حل می‌کنم - چون مریضان در صف هستند و زندگی‌شان در خطر است. فوراً با تدارکات ولایتی تماس می‌گیرم، اول مشکل دوا را

Sample Answer

First, I would prioritize the medicine stock-out because patient lives are at risk. I would immediately contact the provincial logistics team, request support from PPHD, and arrange emergency supply from the nearest facility if possible. Second, I would assign the HMIS Officer to follow up with the 10 facilities that have not submitted reports, while I monitor progress. Third, I would address the finance query from the central office within the deadline, and if I cannot meet it, I would communicate a realistic timeline. Throughout, I would document all actions and follow up.

۱.۱۲ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل اول در شش جمله:

- کلینیک‌ها و جامعه، PPHD، حلقه وصل بین دفتر مرکزی = Coordinator
- چه کار، کی، کجا، چطور، با کدام منبع = Work Plan
- رفتن، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن، پیگیری کردن = Monitoring
- نیست KPI، معیار موفقیت؛ اگر اقدام نداشته باشد = KPI
- قبلاً اتفاق افتاده = Issue ممکن است اتفاق بیفتد؛ Risk
- اول زندگی مردم، بعد خدمات اساسی، بعد راپور، بعد جلسات = Prioritization

پیگیری کن ← راپور بده ← مستند کن ← اقدام کن ← اولویت بده ← بررسی کن ← هفت کلمه طلایی: بفهم

جواب‌های طلایی فصل اول

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
وظیفه اصلی Coordinator چیست؟	و راپوردهی – نه انجام همه کارها همه‌نگی، نظارت، پیگیری	Coordinate, monitor, follow up, and report – not doing everything alone.
با Register مطابقت نداشته باشد؟ اگر معلومات	صحبت کن، اصلاح کن، پیگیری کن کن، تفاوت را مشخص کن، با مسئول با منبع اصلی چک	Verify against source documents, identify the discrepancy, discuss with staff, correct it, and follow up.
اولویت اول در کار چیست؟	زندگی مردم و تداوم خدمات اساسی	Patient safety and continuity of essential health services.
فرق دارد؟ Evaluation با Monitoring چه	در جریان کار است؛ Monitoring بعد از تمام شدن Evaluation	Monitoring is during implementation; evaluation is after completion.
چه فرق دارد؟ Risk با Issue	Issue ممکن است اتفاق بیفتد؛ Risk قبلاً اتفاق افتاده	A risk may happen; an issue has already happened.

نکته آخر فصل اول

کنی و بفرستی، منشی هستی؛ اگر فکر کنی، اولویت بدهی، اقدام کنی و پیگیری کنی Provincial Coordinator هستی – کسی است که فکر می‌کند، تصمیم می‌گیرد و پیگیری می‌کند. اگر فقط معلومات جمع

فصل دوم: راپورنویسی و ارتباطات حرفه‌ای

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. یک راپور ماهوار واقعی را با ساختار کامل (مقدمه، فعالیت‌ها، نتایج، مشکلات، درس‌ها، پلان آینده) می‌نویسی.
۲. خلاصه اجرایی نیم‌صفحه‌ای می‌نویسی که نتیجه را پیش از توضیح می‌گوید.
۳. برای هر مشکل یک پلان اقدام (مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص) می‌سازی.
۴. راپور حادثه‌ای را همان روز آماده می‌کنی.

مهم‌ترین مهارت یک Coordinator

راپور خوب = اعتماد؛ راپور ضعیف = مشکل. راپور خوب سه چیز دارد: واضح، مختصر، قابل اقدام. این کتاب یاد بگیری، همین باشد: راپورنویسی. چون PPHD، دفتر مرکزی و دونر همه از تو راپور می‌خواهند. اگر فقط یک مهارت را در

۲.۱ راپورنویسی (Reporting) – چرا این قدر مهم است؟

مفهوم ساده

اتفاق افتاده – به شکلی که خواننده بفهمد چه کار کردی، چه نتیجه‌ای گرفتی، چه مشکلی داری و چه می‌خواهی. راپور یعنی نوشتن آنچه

راپور خوب:

- واضح: خواننده در یک بار خواندن بفهمد
- مختصر: کوتاه، بدون کلمات اضافی
- قابل اقدام: هر مشکل – راه‌حل، مسئول و زمان دارد
- صادق: نه بزرگ‌نمایی، نه پنهان‌کاری

راپور ضعیف:

- طولانی و پر از کلمات تکراری
- مشکل را می‌گوید، اما راه‌حل ندارد
- آمار می‌دهد، اما تحلیل ندارد
- «همه کارها خوب پیش می‌رود» – بدون معلومات واقعی

اشتباهات رایج

۸۰ راپور ضعیف

از کلینیک‌ها نظارت کردیم. همه چیز خوب بود. بعضی مشکلات کوچک وجود داشت که انشاءالله حل می‌شود. «در ماه جاری»

اشتباهات رایج

۷۰ راپور قوی

را اصلاح کنند. مسئول پیگیری: Coordinator. زمان: تا ۱۵ ماه آینده. راپور پیگیری در ماه بعد ارائه می‌شود. «
 علت: نبود کارمند مسئول تدارکات در ۲ کلینیک. اقدام: به ۴ مسئول کلینیک هدایت داده شد تا Stock Card
 ۵ BHC در ولسوالی‌های نیلی، اشترلی و شهرستان نظارت کردیم. نتیجه: ۴ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند.
 «در ماه جاری از

۲.۲ راپور روایتی (Narrative Report)

مفهوم ساده

نه فقط جدول و آمار. در آن توضیح می‌دهی چه کار کردی، چرا، چطور و چه نتیجه‌ای گرفتی Narrative Report
 یعنی راپوری که به شکل داستان/روایت نوشته می‌شود -

بخش	چه بنویسی؟
۱. مقدمه (Introduction)	راپور برای چه دوره‌ای است؟ کدام ولایت؟ کدام فعالیت‌ها؟ این
۲. فعالیت‌های انجام‌شده	چه کار کردی؟ کجا؟ با کی؟
۳. نتایج (Results)	چه نتیجه‌ای گرفتی؟ آمار و ارقام
۴. مشکلات (Challenges)	چه مشکلی داشتی؟ چرا؟
۵. درس‌ها (Lessons Learned)	چه یاد گرفتی؟ دفعه بعد چه کنی؟
۶. پلان آینده (Way Forward)	ماه/ربع بعد چه کار می‌کنی؟

مثال از دایکندی - راپور ماهوار، ماه حمل ۱۴۰۵

- مقدمه: این راپور فعالیت‌های صبحی ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵ پوشش می‌دهد.
- جلسه هماهنگی با PPHD دایکندی؛ جمع‌آوری راپور HMIS از ۲۰ کلینیک؛ پیگیری تدارکات دوا برای ۳ کلینیک.
- فعالیت‌ها: نظارت از ۵ BHC در ولسوالی‌های نیلی، اشترلی و شهرستان؛ ۲
- نتایج: ۱۹) Rate: ۹۵% (۳۰) Drug Availability: ۸۵% (۳۰) کلینیک کمبود دوا) Attendance Rate: ۹۰% (۳۰)
- علت: نبود کارمند HMIS؛ دوا در BHC شهرستان در ۵ روز اول ماه تمام بود - علت: تأخیر در تدارکات.
- مشکلات: یک کلینیک در ولسوالی اشترلی راپور HMIS نفرستاده
- تأخیر راپور می‌شود - نیاز به آموزش کارمندان موجود؛ برنامه‌ریزی تدارکات باید قبل از زمستان انجام شود.
- درس‌ها: کمبود کارمند HMIS در ولسوالی‌های دور باعث
- در اشترلی تا ۱۵ ثور؛ پیگیری تدارکات دوا برای BHC شهرستان تا ۱۰ ثور؛ نظارت از ۵ BHC دیگر در ماه ثور.
- پلان آینده: آموزش HMIS برای ۲ کارمند

برای امتحان

Introduction: را حفظ نکن - ساختارش را حفظ کن Narrative Report ← Activities ← Results ← Lessons ← Challenges Way Forward.

۲.۳ راپور ماهوار و ربعوار (Monthly/Quarterly Report)

دوره	راپور ماهوار	راپور ربعوار
هر ماه	هر ۳ ماه	
طول	۲-۱ صفحه	۳-۵ صفحه
جزئیات	خلاصه فعالیت‌ها	تحلیل عمیق‌تر، روند (Trend)
برای کی؟	دفتر مرکزی، PPHD	دفتر مرکزی، دونر

چک‌لیست راپور ماهوار خوب

اشتباهات رایج

- ✓ فعالیت‌های اصلی ماه (۳-۵ مورد) ✓ آمار کلیدی (KPIها)
- ✓ مشکلات فوری ✓ اقدامات انجام‌شده

اشتباهات رایج

- ✓ پلان ماه بعد ✓ ضمیمه: راپور HMIS (اگر جدا فرستاده نمی‌شود)

چک‌لیست راپور ربعوار خوب

اشتباهات رایج

- ✓ خلاصه اجرایی (Executive Summary) ✓ مقایسه با ربع قبل (Trend)
- ✓ تحلیل مشکلات - نه فقط لیست ✓ درس‌های آموخته‌شده ✓ پلان ربع بعد

مثال از دایکندی - خلاصه بخش مقایسه ربع اول ۱۴۰۵

HMIS Reporting Rate از ۸۵٪ در ربع قبل به ۹۵٪ افزایش یافت. مشکل اصلی: کمبود دوا در ۳ کلینیک دورافتاده. ۱۲ BHC نظارت کرد، راپور ۲۰ HMIS کلینیک را جمع‌آوری نمود و ۳ جلسه هماهنگی با PPHD برگزار کرد. خلاصه اجرایی: در ربع اول ۱۴۰۵، Coordinator ولایت دایکندی از

شاخص	ربع قبل	ربع جاری	تغییر
Reporting Rate	۸۵٪	۹۵٪	+۱۰٪
Drug Availability	۹۰٪	۸۵٪	-۵٪
Supervision Visits	۱۰	۱۲	+۲

که پیگیری‌های Coordinator مؤثر بوده. کاهش Drug Availability به دلیل تأخیر تدارکات زمستانی است. تحلیل: افزایش Reporting Rate نشان می‌دهد

درس‌ها: برنامه‌ریزی تدارکات باید ۲ ماه قبل از زمستان شروع شود.

پلان ربع بعد: نظارت از ۱۲ BHC دیگر، آموزش HMIS برای ۵ کارمند، پیگیری تدارکات دوا.

۲.۴ خلاصه اجرایی (Executive Summary)**مفهوم ساده**

یعنی خلاصه راپور برای کسی که وقت ندارد کل راپور را بخواند. مدیران ارشد، دونر و Executive Summary معمولاً فقط همین را می‌خوانند PPHD

- کوتاه: نصف صفحه - بیشتر نه
- در ابتدا: نتیجه اصلی را بگو - بعد جزئیات
- مشکلات کلیدی: ۲-۳ مشکل اصلی
- درخواست: اگر چیزی می‌خواهی، واضح بگو

حفظ کن

توضیح بعد. در امتحان، اگر گفتند «خلاصه بنویس» - با نتیجه شروع کن، نه با مقدمه Executive Summary = نتیجه اول،

۲.۵ پلان اقدام (Action Plan)

مفهوم ساده

Action Plan یعنی جدولی که می‌گوید: چه مشکل؟ چه اقدام؟ کی؟ کی مسئول؟ چگونه؟ چگونه می‌شود؟ Action Plan در راپور خیلی مهم است - چون نشان می‌دهد تو فقط مشکل را نمی‌گویی، برای حل آن پلان داری

مشکل	اقدام	مسئول	زمان	شاخص موفقیت
نیست Stock Card به روز	+ پیگیری هفتگی آموزش مجدد	Coordinator	تا ۱۵ ماه	به روز Stock Card
HMIS دیر می‌شود راپور	هفتگی با کلینیک‌ها تماس	HMIS Officer	هر هفته	Reporting Rate > ۹۵%
دوا تمام شده	فوری به تدارکات درخواست	Coordinator	فوری	دوا در ۱ هفته

مثال از دایکندی - Action Plan نظارت BHC نیلی، ماه حمل ۱۴۰۵

مشکل	اقدام	مسئول	زمان	شاخص موفقیت
است TB Register ناقص	مجدد مسئول TB آموزش	Coordinator + HMIS Officer	تا ۱۰ ثور	ثبت TB کامل
نیست Stock Card به روز	هفتگی + چک مجدد پیگیری	Coordinator	هر هفته	به روز Stock Card
ثبت نمی‌شود حاضری کارمندان	به مسئول کلینیک یادآوری	Coordinator	فوری	روزانه ثبت شود حاضری

۲.۶ چالش‌ها و درس‌های آموخته‌شده (Challenges & Lessons Learned)

Lessons Learned	Challenges	
چپست؟	مشکلاتی که در کار داشتی	چه یاد گرفتی که دفعه بعد بهتر کنی
مثال	«دوا دیر رسید»	تدارکات را قبل از زمستان شروع کنم» «باید»
برای کی؟	برای شفافیت	برای بهبود

برای امتحان

را پنهان نکن. Coordinator خوب = کسی که مشکلات را صادقانه می‌نویسد و برای آن‌ها راه حل پیشنهاد می‌کند. در راپور، هیچ وقت مشکل

۲.۷ راپور حادثه‌ای (Incident Report)

مفهوم ساده

راپور فوری درباره یک حادثه – مثل حمله، دزدی، مرگ کارمند، آتش‌سوزی یا مشکل امنیتی Incident Report یعنی.

بخش	چه بنویسی؟
۱. تاریخ و وقت	کی اتفاق افتاد؟
۲. مکان	کجا؟ کدام کلینیک/ولسوالی؟
۳. شرح حادثه	چه اتفاق افتاد؟
۴. افراد متأثر	کی آسیب دید؟
۵. اقدام فوری	چه کار کردی؟
۶. اقدام بعدی	چه پلانی داری؟

حفظ کن

فوری؛ نه یک هفته بعد. اگر حادثه امنیتی یا صحتی جدی است، همان روز راپور بده = Incident Report

۲.۸ راپورنویسی – اشتباهات رایج

اشتباهات رایج

- × اشتباه ۱: راپور طولانی و پر از کلمات تکراری.
- ✓ درست: کوتاه، واضح، با جدول و آمار.

اشتباهات رایج

- × اشتباه ۲: فقط مشکل را گفتن، بدون راه‌حل.
- ✓ درست: هر مشکل باید Action Plan داشته باشد.

اشتباهات رایج

- × اشتباه ۳: آمار دادن بدون تحلیل.
- ✓ درست: «Reporting Rate ۷۰٪ است» + «چرا؟» + «چه اقدام؟»

اشتباهات رایج

- × اشتباه ۴: پنهان کردن مشکلات.
- ✓ درست: مشکلات را صادقانه بنویس – PPHD و دفتر مرکزی برای کمک هستند.

اشتباهات رایج

۸۰ اشتباه ۵: دیر فرستادن راپور.

۷۰ درست: راپور به موقع = اعتماد؛ راپور دیر = مشکل.

۲.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

راپور نفرستاده - علت: نبود کارمند؛ جلسه با ۲ PPHD جلسه. سؤال: راپور ماهوار بنویس - با ساختار کامل. HMIS از ۲۰ کلینیک؛ Drug Availability: ۸۰٪؛ ۳ کلینیک Stock Card به روز نداشتند؛ یک کلینیک در اشتراک ولایت دایکندی هستی. راپور ماهوار را باید بنویسی. معلومات: نظارت از ۴ BHC؛ ۱۷ Reporting Rate: ۸۵٪ تو Coordinator

جواب مدل - راپور ماهوار، ماه حمل ۱۴۰۵

موجود در اشتراک تا ۱۵ ثور؛ پیگیری Stock Card در ۳ کلینیک تا ۱۰ ثور؛ درخواست دوا از تدارکات - فوری. نبود کارمند HMIS در ولسوالی‌های دور باعث تأخیر راپور می‌شود. ۶. پلان آینده: آموزش HMIS برای کارمند HMIS نفرستادند (یکی در اشتراک به دلیل نبود کارمند)؛ Drug Availability ۸۰٪ - ۲۰٪ کمبود. ۵. درس‌ها: Supervision Visits: ۴.۴؛ Drug Availability: ۸۰٪؛ ۳ کلینیک Stock Card به روز نداشتند؛ ۳ کلینیک راپور جمع‌آوری راپور HMIS از ۱۷ کلینیک. ۳. نتایج: ۱۷ Reporting Rate: ۸۵٪ (۱۷ از ۲۰)؛ Drug Availability: ۸۰٪؛ ۲. فعالیت‌ها: نظارت از ۴ BHC در ولسوالی‌های نیلی و شهرستان؛ ۲ جلسه هماهنگی با PPHD؛ ۱. مقدمه: این راپور فعالیت‌های صحتی ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵ پوشش

مشکل	اقدام	مسئول	زمان
Stock Card	پیگیری + آموزش	Coordinator	۱۰ ثور
دیر HMIS	آموزش کارمند	HMIS Officer	۱۵ ثور
کمبود دوا	درخواست تدارکات	Coordinator	فوری

Sample Answer

Monthly Report - Daikundi Province - Hamal 1405. 1. Introduction: This report covers health activities in Daikundi during Hamal 1405. 2. Activities: Supervised 4 BHCs; held 2 coordination meetings with PPHD; collected HMIS reports from 17 facilities. 3. Results: HMIS Reporting Rate: 85%; Drug Availability: 80%. 4. Challenges: 3 facilities had incomplete stock cards; 3 facilities did not submit HMIS reports; 20% drug shortage. 5. Lessons Learned: Lack of HMIS staff in remote districts causes reporting delays. 6. Way Forward: Train existing staff on HMIS in Ashtarlay; follow up on stock cards; request emergency drug supply. Action Plan: [table with issue, action, responsible, deadline]

۲.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• راپور خوب = واضح + مختصر + قابل اقدام.

Way← Lessons ← Challenges ← Results ← Activities ←• Narrative Report = Introduction Forward.

- نتیجه اول، توضیح بعد - نصف صفحه Executive Summary
- مشکل + اقدام + مسئول + زمان + شاخص = Action Plan
- صادقانه بنویس، پنهان نکن = Challenges & Lessons Learned
- فوری - همان روز = Incident Report

Action Plan ← پلان آینده ← درس‌ها ← مشکلات ← نتایج ← فعالیت‌ها ← ساختار طلایی راپور: مقدمه

جواب‌های طلایی فصل دوم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
راپور خوب چه ویژگی دارد؟	واضح، مختصر، قابل اقدام، صادق	Clear, concise, actionable, and honest.
چطور بنویسی؟ Executive Summary	نتیجه اول، توضیح بعد - نصف صفحه	Start with the main result, then explain briefly - half a page.
اگر مشکلی در راپور داشته باشی؟	صادقانه بنویس + Action Plan بده	Write it honestly and include an action plan.
کی بفرستی؟ Incident Report	همان روز - فوری	Same day - immediately.
چه ستون‌هایی دارد؟ Action Plan	اقدام، مسئول، زمان، شاخص موفقیت، مشکل	Issue, action, responsible, deadline, success indicator.
راپور ماهوار با ربعوار چه فرق دارد؟	- ربعوار تحلیل عمیق‌تر و مقایسه‌ای ماهوار خلاصه‌تر	Monthly is shorter; quarterly includes deeper analysis and trends.

نکته آخر فصل دوم

کار کردی، چه مشکلی داری و چه می‌خواهی - راپور تو موفق است؛ اگر بگویند «این چه بود؟» - دوباره بنویس. راپورنویسی = هنر نوشتن کوتاه و مفید. اگر PPHD راپور تو را بخواند و بگویند «فهمیدم چه

نظام صحتی افغانستان، DHIS2 و MoPH، PPHD، HMIS

فصل سوم:

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. سه سطح نظام صحتی افغانستان و وظیفه هر سطح را توضیح می‌دهی.
۲. تفاوت BPHS و EPHS و معیار جمعیتی هر نوع مرکز صحتی را می‌دانی.
۳. زنجیره معلومات صحتی (Register ← HMIS ← DHIS2 ← PPHD ← MoPH) را می‌شناسی (MoPH)
۴. می‌دانی امروز خدمات اساسی از چه راه تأمین می‌شود و نقش MoPH، WHO، UNICEF و PPHD چیست.

چرا این فصل مهم است؟

نمی‌توانی هماهنگ کنی. در امتحان، سؤالات زیاد از ساختار صحتی، BPHS/EPHS و HMIS می‌آید. تو Coordinator صحتی هستی. اگر نظام صحتی را نشناسی،

۳.۱ ساختار صحتی افغانستان

مفهوم ساده

نظام صحتی افغانستان سه سطح دارد:

سطح	خدمات	مراکز
سطح اول - قریه	خدمات اولیه صحتی (Primary Care)	Health Post، BHC، CHC
سطح دوم - ولسوالی	خدمات ثانوی (Secondary Care)	شفاخانه ولسوالی، شفاخانه ولایتی
سطح سوم - مرکز	خدمات تخصصی (Tertiary Care)	مرکزی، شفاخانه‌های تخصصی شفاخانه‌های

وزارت صحت عامه (MoPH) در راس قرار دارد:

وزیر صحت عامه؛ در کنار او چهار معینیت - خدمات صحتی، پالیسی و انکشاف، طب و غذا، و مالی و اداری.

• در رأس وزارت:

(Provincial Health Coordination)، ریاست صحت اولیه (PHC)، ریاست صحت مادر و طفل، و ریاست پلان و هماهنگی. عمومی و تصدی‌های تخصصی کار می‌کنند - از جمله ریاست هماهنگی صحت ولایات (Coordination) زیر هر معینیت، ریاست‌های

عالی صحت عامه و بورد اجرائیه وزارت، نهادهای مشورتی و هماهنگی برای تصمیم‌گیری‌های کلان صحتی اند.

• شورای

در سطح ولایت:

هماهنگی تمام فعالیت‌های صحتی در ولایت را دارد: PPHD (Provincial Public Health Directorate).

ریاست صحت عامه ولایت - مسئولیت

هماهنگی صحتی ولایت - تمام شریکان: PPHCC (Provincial Public Health Coordination Committee).

در آن اشتراک می‌کنند (MoPH، UN، NGO) کمیته

مثال از دایکندی

یا هر ربع جلسه می‌کند. تو باید در این جلسات اشتراک کنی، راپور SO را شریک کنی و مشکلات را مطرح کنی. تو SO Coordinator در دایکندی هستی. PPHD دایکندی رئیس دارد. PPHCC هر ماه

EPHS و BPHS ۳.۲

EPHS	BPHS	
بسته خدمات شفاخانه‌ای	بسته خدمات صحتی اساسی	چیست؟
۲۰۰۵	۲۰۰۳	کی ساخته شد؟
خدمات شفاخانه‌ای، جراحی، تخصص‌ها	صحت اولیه، وقایه، صحت مادر و طفل	چه خدماتی؟
شفاخانه ولسوالی، شفاخانه ولایتی	Health Post، BHC، CHC	کجا؟

خدمات سطح شفاخانه و حمایت ارجاعی EPHS. خدمات صحت اولیه و وقایه را ارائه می‌دهد BPHS. را شامل می‌شود BPHS برای مراکز (Referral)

مرکز	سطح	خدمات
Health Post	قریه	خدمات ابتدایی، ارجاع ساده
BHC (Basic Health Center)	قریه/ولسوالی	اساسی – صحت مادر، طفل، واکسین خدمات
CHC (Comprehensive Health Center)	ولسوالی	خدمات گسترده‌تر + تخت
شفاخانه ولسوالی	ولسوالی	BPHS + EPHS (مختلط)
شفاخانه ولایتی	ولایت	EPHS

آمار مهم

• ساحات بسیار دور، کمتر از ۱۵,۰۰۰ نفر BHC (برای هر ۱,۵۰۰-۱,۰۰۰ نفر (۱۵۰-۱۰۰ خانواده Health Post •
 نفر • شفاخانه ولایتی برای هر ۲۰۰,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۰ نفر (معیارهای CHC • (برای هر ۱۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰ نفر (در
 (وزارت صحت عامه، BPHS، برای هر ۳۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰ نفر • شفاخانه ولسوالی برای هر ۱۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰
 دو ساعته به خدمات صحتی دسترسی داشتند (منبع: WHO EMRO – Health Systems, Afghanistan).
 • در سال ۲۰۱۸ در افغانستان ۳,۱۳۵ مرکز صحتی فعال ثبت شده بود و نزدیک به ۸۷٪ مردم در فاصله

مثال از دایکندی

است. اگر یک مریض نیاز به جراحی داشته باشد، به شفاخانه ولایتی دایکندی BPHS نیلی یک مرکز BHC ارجاع داده می‌شود. اگر نیاز به تخصص بالاتر باشد، به کابل فرستاده می‌شود (EPHS)

حفظ کن

(خدمات شفاخانه‌ای (ولسوالی/ولایت = EPHS | (خدمات اولیه صحتی (قریه/ولسوالی = BPHS

سیستم معلومات صحتی - HMIS ۳.۳

مفهوم ساده

ذخیره، تحلیل و شریک کردن معلومات صحتی (Health Management Information System) HMIS. یعنی سیستم جمع‌آوری،

چطور کار می‌کند؟ HMIS

مرکز صحتی (Register)

جمع‌آوری معلومات ماهانه

فرستادن به PPHD/سازمان - تا هفتم ماه بعد (۷ روز پس از پایان ماه)

فرستادن راپور ربعوار به مرکز - تا پایان ماه اول ربع جدید

تحلیل و استفاده

مرحله	کی؟
مرکز صحتی معلومات را جمع می‌کند	پایان هر ماه
راپور به PPHD/سازمان فرستاده می‌شود	تا هفتم ماه بعد (۷ روز پس از پایان ماه)
به مرکز می‌فرستد PPHD	پایان ماه اول ربع جدید

مثال از دایکندی

جمع می‌کند. راپور ماهانه را قبل از ۷ ثور به Register نیلی در پایان ماه حمل، تمام معلومات مریضان را از BHC به‌موقع فرستاده شده و معلومات دقیق است (Coordinator) ولایتی می‌فرستد. تو SO دایکندی و دفتر PPHD. باید چک کنی که این راپور

برای امتحان

اگر تفاوت باشد، باید بررسی کند، اصلاح کند و پیگیری کند Register مسئولیت دارد که معلومات با Coordinator. مطابقت داشته باشد.

سیستم معلومات صحتی دیجیتال - DHIS2 ۳.۴

مفهوم ساده

و در سطح بین‌المللی هم استفاده می‌شود MoPH یک سیستم معلومات صحت دیجیتال است که توسط DHIS2 این سیستم برای جمع‌آوری، ذخیره، تحلیل و شریک کردن معلومات از جوامع و مراکز صحت طراحی شده استفاده می‌شود.

چه کار می‌کند؟ DHIS2

- معلومات را از مراکز صحت جمع می‌کند
- تحلیل و گزارش‌دهی خودکار
- شاخص‌ها را محاسبه می‌کند
- دسترسی به معلومات را آسان می‌کند

مثال از دایکندی

از دفتر ولایتی معلومات را ببینی و تحلیل کنی - مثلاً ببینی که ANC Coverage در یک ولسوالی کم است. در BHC نیلی، کارمند HMIS معلومات مریضان را در DHIS2 ثبت می‌کند. تو می‌توانی

حفظ کن

(سیستم معلومات صحت دیجیتال) DHIS2 = (نرم‌افزار) | (سیستم معلومات صحت) HMIS =

3.5 Register و اسناد اصلی

مفهوم ساده

منبع اصلی معلومات Register. یعنی دفتری که مرکز صحت در آن معلومات مریضان را ثبت می‌کند Register است (Source Document).

انواع Register:

- OPD Register: مریضان سرپایی
- ANC Register: مریضان زن باردار
- Delivery Register: ولادت‌ها
- TB Register: مریضان TB
- Vaccination Register: واکسین‌ها
- Stock Card: موجودی دوا

مثال از دایکندی

گرفته‌اند. تو ANC Register را چک می‌کنی. اگر فقط ۳۵ ثبت شده باشد، تفاوت ۱۵ نفر است. باید بپرسی: چرا؟ تو به BHC نیلی می‌روی. راپور HMIS می‌گویند ۵۰ زن باردار ANC

برای امتحان

همیشه بپرس: آیا معلومات با Register مطابقت دارد؟ اگر نه - چرا؟ چه اقدامی لازم است؟

۳.۶ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

وقتی به Register کلینیک مراجعه می‌کنی، فقط ۷۰ مریض ثبت شده. تفاوت: ۳۰ مریض. سؤال: چه می‌کنی؟ ولایت دایکندی هستی. راپور HMIS نشان می‌دهد که BHC اشتراکی در ماه گذشته ۱۰۰ مریض OPD داشته، اما تو Coordinator

جواب مدل

باشد آموزش کوتاه می‌دهم. در راپور نظارت مستند می‌کنم و به PPHD اطلاع می‌دهم. هفته بعد پیگیری می‌کنم. بفهمم کدام درست است. اگر مشکل ثبت باشد، به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که اصلاح کند؛ اگر لازم HMIS به اشتباه ثبت شده. با چک کردن اسناد دیگر (مثلاً Stock Card - چند دوا مصرف شده؟) می‌توانم و راپور HMIS مطابقت ندارند. ممکن است چند دلیل داشته باشد: Register ناقص ثبت شده، یا معلومات اول با مسئول کلینیک صحبت می‌کنم و از او می‌پرسم چرا Register

Sample Answer

First, I would discuss with the facility in-charge to understand the discrepancy. I would check other source documents, such as the pharmacy stock card and OPD register, to verify which data is accurate. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure the register is updated, document the findings, report to PPHD, and follow up to confirm the data is accurate in the next reporting period.

۳.۷ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- نظام صحتی افغانستان سه سطح دارد: قریه، ولسوالی، مرکز.
- خدمات شفاخانه‌ای = EPHS خدمات اولیه صحتی؛ BPHS =
- برای هر ۱۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰ نفر - شفاخانه ولسوالی برای هر ۱۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰ نفر BHC
- سیستم جمع‌آوری معلومات صحتی = HMIS
- سیستم معلومات صحتی دیجیتالی = DHIS2
- مطابقت داشته باشد Register منبع اصلی معلومات؛ راپور باید با Register =

تحلیل → مرکز → PPHD/NGO → راپور ماهانه → ساختار طلایی: Register

۳.۸ نظام صحتی افغانستان امروز (۱۴۰۵) - چیزهایی که در کار روزمره می‌بینی

مفهوم ساده

تغییر کرده است. Coordinator باید این تفاوت را بداند تا بفهمد راپورش به کی می‌رسد و تصمیم از کجا می‌آید. ساختار BPHS/EPHS همان است که در بخش ۳.۲ خواندی، اما روش تأمین خدمات و پول آن بعد از ۲۰۲۱

چطور خدمات اساسی تأمین می‌شود؟

و نظارت را دارد؛ خدمات را سازمان‌های غیردولتی (Service Providers) در هر ولایت تطبیق می‌کنند.

- وزارت صحت عامه (MoPH) پالیسی، معیار
- شفاخانه‌ای است؛ پول آن از طریق صندوق‌های مشترک (مثل ARTF/بانک جهانی و ADB) تأمین می‌شود.
- به سازمان ملل منتقل شد: UNICEF مسئول خدمات صحت اولیه و WHO مسئول بخش عمده خدمات
- بعد از ۲۰۲۱، مدیریت قراردادهای BPHS/EPHS
- مستقیم MoPH اجرا می‌شد؛ پس برنامه‌های فعلی ادامه همان مدل contracting-out است.
- در دوره قبلی همین خدمات زیر پروژه «صحت‌مندی» (Sehatmandi) و قراردادهای
- از (Shuhada Organization) در ولایت، نقش هماهنگی، نظارت و تأیید را دارد؛ سازمان تو PPHD
- ها است Service Provider یکی

چه چیزی در چند سال اخیر تغییر کرده؟

به صورت محسوس کم شد و در ۲۰۲۵ نیز با قطع بخشی از کمک‌ها، صدها مرکز دیگر به تعلیق رفت.

کاهش یافته است. در اوج (اواخر دهه ۲۰۱۰) بیش از ۳,۰۰۰ مرکز فعال بود؛ در سال‌های بعد این تعداد

- تعداد مراکز صحتی فعال
- آسیب دیده است؛ این یعنی Stock-out و ترک وظیفه کارمندان در ولایات دور، ریسک‌های روزمره است.
- تأمین دوا، حقوق کارمندان و بعضی برنامه‌های صحتی
- کمک‌ها برای برنامه‌های صحتی عامه تا پایان ۲۰۲۶ تمدید شده؛ اما شرایط مالی بی‌ثبات است.

این برای Coordinator چه معنی دارد؟

راپور و نظارت تو، برای ادامه پول و ادامه خدمات مهم است - گزارش دقیق = دفاع از خدمات برای مردم.

۱.

وظیفه را مستند کن؛ این معلومات به PPHD و UNICEF/WHO کمک می‌کند تا برای ولایت تو منابع بگیرند.

۲. هر Stock-out یا ترک

و شاید سازمان تطبیق‌کننده در ولایت عوض شوند. رابطه کاری با PPHD را نگه دار و اسناد را منظم نگه دار.

۳. انتظار تغییر داشته باش: شرکای تأمین‌کننده، پروژه‌ها

دقیق و به‌روز، راپورترین و بلندترین منبع را نخوان - با PPHD ولایت خودت و دفتر مرکزی تماس بگیر.

۴. برای معلومات

چه چیزی را بازبینی کن (تابستان ۱۴۰۵): گزارش‌دهی ولایت خودت - چون ممکن است تغییر کرده باشد.

نام پروژه فعلی، شریک مالی، و کانال

جواب‌های طلایی فصل سوم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
چه فرق دارد؟ BPHS با EPHS	EPHS خدمات اولیه صحتی است؛ BPHS خدمات شفاخانه‌ای	BPHS provides primary health care; EPHS provides hospital-level services.
چیست؟ HMIS	ذخیره و تحلیل معلومات صحتی سیستم جمع‌آوری،	A system for collecting, storing, and analyzing health data.

چيست؟ DHIS2	سيستم معلومات صحتي ديگيتال	A digital health information system.
با Register مطابقت نداشته باشد؟ اگر معلومات	علت را پيدا كن، اصلاح كن، پيگيري كن بررسی كن،	Verify, identify the cause, correct it, and follow up.
چيست؟ PPHD	رياست صحت عامه ولايت	Provincial Public Health Directorate.
چيست؟ PPHCC	کميته هماهنگی صحتي ولايت	Provincial Public Health Coordination Committee.

نکته آخر فصل سوم

نظام صحتي را بشناس تا بتوانی هماهنگ کنی. Register → HMIS → DHIS2 → PPHD → را حفظ کن – MoPH
این زنجير

فصل چهارم: تدارکات، دوا، لوژستیک و دارایی‌ها

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. چرخه تدارکات (نیاز ← درخواست ← تأیید ← خریداری ← تحویل ← ثبت) را توضیح می‌دهی.
۲. محاسبه می‌کنی و برای موجودی تصمیم می‌گیری Reorder Point و AMC.
۳. فوراً مدیریت می‌کنی و علت ریشه‌ای آن را پیدا می‌کنی Stock-out.
۴. پلان زمستانی‌سازی و حفظ زنجیره سرد را برای مراکز دورافتاده می‌نویسی.

چرا این فصل مهم است؟

Coordinator مسئولیت دارد که دوا به‌موقع برسد، موجودی مدیریت شود و از Stock-out جلوگیری کند. در محیط صحت، دوا = زندگی. اگر دوا نباشد، جان مریض در خطر است.

۴.۱ تدارکات (Procurement)

مفهوم ساده

ها، تدارکات معمولاً از طریق درخواست خرید NGO یعنی خریداری دوا، تجهیزات و سایر اقلام. در Procurement شروع می‌شود (Purchase Requisition). شناسایی نیاز ← درخواست خرید (Requisition)

تأیید از Coordinator

ارسال به دفتر مرکزی/تدارکات

خریداری (Procurement)

تحویل به مرکز صحت

ثبت در Stock Card

مثال از دایکندی

می‌رساند (Coordinator) دارد. مسئول کلینیک درخواست خرید می‌دهد. تو Paracetamol نیلی نیاز به BHC که نیاز واقعی است. درخواست به دفتر مرکزی ولایتی می‌رود. تدارکات دوا را خریداری می‌کند و به کلینیک تأیید می‌کنی.

حفظ کن

Recording → Delivery → Procurement → Approval → Requisition

۴.۲ مصرف متوسط ماهانه (AMC)

مفهوم ساده

باید سفارش بدهیم AMC یعنی میانگین مصرف ماهانه یک دوا. از AMC (Average Monthly Consumption) استفاده می‌شود تا بفهمیم یک دوا چقدر باقی می‌ماند و کی

مجموع مصرف در ۳ ماه $AMC = 3$

مثال از دایکندی

دلو: ۲۸۰ دانه • حوت: ۳۲۰ دانه • Paracetamol نیلی در ۳ ماه گذشته: جدی: ۳۰۰ دانه BHC
مجموع: ۹۰۰ = ۳۰۰ دانه در ماه. اگر موجودی فعلی ۶۰۰ دانه باشد، یعنی برای ۲ ماه کافی است.

برای امتحان

استفاده می‌شود Reorder Point میانگین مصرف ماهانه؛ از آن برای محاسبه $AMC =$

۴.۳ موجودی (Stock) و Stock Card

مفهوم ساده

مقدار مصرف، موجودی باقی‌مانده و تاریخ انقضا Stock Card یعنی کارت ثبت موجودی. هر دوا یک Stock Card دارد. در آن ثبت می‌شود: تاریخ دریافت، مقدار دریافت، تاریخ مصرف،

نمونه Stock Card – Paracetamol 500mg – BHC نیلی

تاریخ	شرح	دریافت	مصرف	موجودی
۱ حمل	موجودی اولیه	—	—	۵۰۰
۵ حمل	دریافت از تدارکات	۳۰۰	—	۸۰۰
۱۰ حمل	مصرف OPD	—	۱۰۰	۷۰۰
۲۰ حمل	مصرف OPD	—	۱۵۰	۵۵۰

Physical Count

هر ماه باید موجودی فیزیکی شمرده شود و با Stock Card مقایسه شود. اگر تفاوت باشد، باید بررسی شود.

حفظ کن

شمردن فیزیکی موجودی = Physical Count | کارت ثبت موجودی = Stock Card

۴.۴ نقطه سفارش مجدد (Reorder Point)

مفهوم ساده

یعنی مقدار موجودی که وقتی به آن رسید، باید فوراً سفارش بدهی Reorder Point

زمان تحویل (به ماه) + ذخیره احتیاطی Reorder Point = AMC

مثال از دایکندی

(دانه؛ زمان تحویل = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه (۶۰۰ دانه AMC = ۳۰۰

دانه – یعنی وقتی موجودی به ۹۰۰ دانه رسید، باید سفارش بدهی $\text{Reorder Point} = ۳۰۰ + ۱ + ۶۰۰ = ۹۰۰$

برای امتحان

اگر موجودی به Reorder Point رسید و سفارش ندادی → می‌شود Stock-out

۴.۵ کمبود دوا (Stock-out) – چطور مدیریت کنیم؟

مفهوم ساده

Risk است – نه Issue یعنی دوا تمام شده و مریض نمی‌تواند خدمات بگیرد. این یک Stock-out

علت	اقدام
تدارکات دیر رسیده	پیگیری فوری + اطلاع به PPHD
مصرف زیاد از حد انتظار	بررسی علت + اصلاح سفارش بعدی
ثبت نشده Stock Card	آموزش + پیگیری
مشکل امنیتی در راه	هماهنگی با PPHD + منابع محلی

مثال از دایکندی – BHC شهرستان دوا تمام کرده

- با تدارکات ولایتی تماس می‌گیری ۲. از PPHD کمک می‌خواهی
- اگر ممکن باشد از BHC نزدیک‌تر دوا قرض می‌گیری ۴. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهی
- پیگیری می‌کنی تا دوا برسد

برای امتحان

در سناریو Stock-out، اولویت اول = حل فوری. بعد علت را پیدا کن. بعد پیگیری کن.

۴.۶ زمستانی‌سازی (Winterization)

مفهوم ساده

و تجهیزات را به مراکز دورافتاده برسانی، سوخت و گرمی‌کننده تهیه کنی و ذخیره احتیاطی بسازی Winterization یعنی آمادگی برای زمستان. در دایکندی، راه‌ها در زمستان بسته می‌شود. باید قبل از زمستان: دوا زنجیره سرد (Cold Chain) انبارهای زنجیره سرد برای واکسین‌ها باید دمای ۲- تا ۸- درجه سانتی‌گراد را حفظ کنند.

مثال از دایکندی

در ولسوالی‌های اشتزلی و کیتی. اگر تا قوس نرسانی، راه‌ها بسته می‌شود و مراکز صحتی بدون دوا می‌مانند. در ماه میزان باید شروع کنی به فرستادن دوا و تجهیزات به BHC‌های دورافتاده

حفظ کن

آمادگی قبل از زمستان. شروع: ماه میزان - نه قوس. اگر دیر کنی، راه بسته می‌شود = Winterization

۴.۷ مدیریت دارایی‌ها (Asset Management)

مفهوم ساده

و موقعیت Asset Register. یعنی دارایی‌های سازمان - مثل موتور، کامپیوتر، تجهیزات طبی و فرنیچر Asset. دفتری است که تمام دارایی‌ها در آن ثبت می‌شود - با شماره، تاریخ خرید، قیمت

مثال از دایکندی

ثبت شده: شماره اموال، تاریخ خرید، قیمت، مسئول استفاده. هر سال باید Physical Verification انجام شود. یک کامپیوتر در دفتر ولایتی SO در نیلی موجود است. در Asset Register

۴.۸ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

بدهی؟ چرا؟ AMC = ۱۵۰. موجودی ۲۰۰ دانه است Amoxicillin نیلی نشان می‌دهد که Stock Card BHC دانه؛ زمان تحویل = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه. سؤال: آیا باید سفارش

جواب مدل

دیر کنی. Reorder Point. موجودی فعلی ۲۰۰ دانه است - کمتر از ۴۵۰ = ۱۵۰ + ۳۰۰ = Reorder Point می‌شود Stock-out، یعنی باید فوراً سفارش بدهی؛ اگر

Sample Answer

Reorder Point = AMC Lead Time + Safety Stock = 150 1 + 300 = 450. Current stock is 200, which is below the reorder point. I must place an order immediately to prevent a stock-out.

۴.۹ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- خریداری دوا و تجهیزات = Procurement
- میانگین مصرف ماهانه = AMC
- شمردن فیزیکی = Physical Count کارت ثبت موجودی؛ = Stock Card
 - زمان تحویل + ذخیره احتیاطی = Reorder Point = AMC
 - فوراً حل کن، بعد علت را پیدا کن = Stock-out = Issue
 - آمادگی قبل از زمستان - شروع از میزان = Winterization

فرمول طلایی: $\text{Reorder Point} = (\text{AMC} \times \text{Lead Time}) + \text{Safety Stock}$

جواب‌های طلایی فصل چهارم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
چیست؟ AMC	میانگین مصرف ماهانه	Average Monthly Consumption.
چیست؟ Stock Card	کارت ثبت موجودی دوا	A card for recording drug stock movements.
چطور محاسبه می‌شود؟ Reorder Point	زمان تحویل + ذخیره احتیاطی AMC	AMC Lead Time + Safety Stock.
اگر دوا Stock-out شود چه می‌کنی؟	حل کن، علت را پیدا کن، پیگیری کن فوراً	Solve immediately, find the cause, and follow up.
چیست؟ Winterization	آمادگی قبل از زمستان برای رساندن دوا	Preparing before winter to deliver medicines to remote facilities.
چیست؟ Physical Count	شمردن فیزیکی موجودی	Physically counting stock on hand.

نکته آخر فصل چهارم

دوا = زندگی؛ اگر Stock-out شود، مریض آسیب می‌بیند. Stock Card → AMC → Reorder Point → حفظ کن. پیگیری - این چرخه را

فصل پنجم: مدیریت مالی

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. بودجه، پلان شده و واقعی را با هم مقایسه می‌کنی و Variance را محاسبه می‌کنی.
۲. می‌گیری و آن را با اسناد درست تصفیه می‌کنی Advance.
۳. اسناد حمایتی هر مصرف را می‌شناسی و می‌دانی بدون سند چه می‌شود.
۴. خود را برای Audit داخلی و خارجی آماده می‌کنی.

چرا این فصل مهم است؟

چطور تصفیه می‌شود و چطور راپور داده می‌شود. اگر مالی را نفهمی، نمی‌توانی تدارکات Coordinator و فعالیت‌ها را مدیریت کنی HR، باید بدانند پول چطور مصرف می‌شود،

۵.۱ بودجه (Budget)

مفهوم ساده

یعنی پلان پولی: برای چه فعالیتی، چقدر پول، در چه زمانی Budget

نوع	مثال
بودجه ماهانه	مصرف ماهانه دفتر
بودجه ربعوار	فعالیت‌های ربع
بودجه سالانه	پلان سالانه

مثال از دایکندی

۵۰,۰۰۰ افغانی؛ تدارکات دوا ۳۰,۰۰۰ افغانی؛ سوخت و ترانسپورت ۱۰,۰۰۰ افغانی؛ مجموع: ۹۰,۰۰۰ افغانی. بودجه ماهانه SO در دایکندی ممکن است شامل: معاشات کارمندان

۵.۲ پلان شده در مقابل واقعی (Planned vs Actual)

مفهوم ساده

چقدر واقعاً مصرف کردی = Actual چقدر پلان کردی؛ = Planned

پلان شده	واقعی	تفاوت	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	معاشات
۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-۵,۰۰۰	دوا
۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	+۲,۰۰۰	سوخت

حفظ کن

مقایسه پلان با واقعیت = Planned vs Actual

۵.۳ تفاوت بودجه (Variance)

مفهوم ساده

یعنی تفاوت بین مقدار پلان شده و مقدار واقعی Variance

مثال: پلان مصرف دوا ۳۰,۰۰۰ افغانی؛ مصرف واقعی ۳۵,۰۰۰ افغانی → افغانی ۵,۰۰۰ = Variance

اما سؤال مهم فقط «چقدر تفاوت است؟» نیست. Coordinator باید بپرسد:

- چرا؟ - آیا موجه است؟ (مثلاً قیمت دوا بلند شده یا مصرف زیاد شده؟)
- آیا مشکل است؟ - اگر Variance بزرگ باشد، باید بررسی شود.
- چه اقدامی لازم است؟ - اصلاح بودجه ماه بعد؟ گزارش به دفتر مرکزی؟

برای امتحان

مثبت باشد Variance اگر $\text{Variance} = \text{Planned} - \text{Actual}$ ← کمتر مصرف شده؛ اگر منفی باشد ← شده. بیشتر مصرف

۵.۴ پیش پرداخت (Advance)

مفهوم ساده

یعنی پولی که قبل از مصرف به یک کارمند یا دفتر داده می شود - برای انجام یک فعالیت Advance

مثال از دایکندی

تو Advance می گیری برای سفر نظارتی به ولسوالی اشتدرلی. بعد از سفر، باید تصفیه کنی.

حفظ کن

راپور مصرف پول + اسناد = (Clearance) پول پیش پرداخت | تصفیه = Advance

۵.۵ تصفیه پیش‌پرداخت (Advance Clearance)

مفهوم ساده

یعنی ثابت کنی پول را برای همان کاری که گرفتی، مصرف کردی - Advance یعنی تصفیه Clearance اسناد مورد نیاز برای تصفیه:

- فاکتور (Invoice) • رسید (Receipt)
- لیست حاضری (اگر مربوط به آموزش باشد) • راپور سفر (اگر مربوط به نظارت باشد)

مثال از دایکندی

۱,۰۰۰ (رسید داری). مجموع: ۹,۰۰۰ افغانی. باقی ۱,۰۰۰ افغانی را برمی‌گردانی و اسناد را تصفیه می‌کنی Advance ۱۰,۰۰۰ افغانی برای سفر نظارتی به اشتراکی. مصرف: سوخت ۶,۰۰۰ (رسید داری)؛ غذا ۲,۰۰۰ (رسید داری)؛ متفرقه گرفتگی:

برای امتحان

باید در زمان مشخص تصفیه شود. اگر دیر کنی، مشکل مالی می‌شود Advance

۵.۶ اسناد حمایتی (Supporting Documents)

مفهوم ساده

رسید (Invoice) یعنی اسنادی که ثابت می‌کند پول درست مصرف شده: فاکتور Supporting Documents (Activity Report) راپور فعالیت، (Attendance Sheet) لیست حاضری، (Contract) قرارداد، (Receipt)

حفظ کن

هیچ مصرفی بدون سند قبول نمی‌شود. No document = No payment

۵.۷ پول نقد (Cash) و مدیریت آن

مفهوم ساده

مدیریت Cash یعنی کنترل پول نقد - چقدر داری، چقدر مصرف کردی، چقدر باقی مانده. اصول اساسی:

- روزانه یا هفتگی Cash Count
- ثبت در Cash Book
- هیچ پولی بدون سند مصرف نشود
- قفل باشد Cash Box

مثال از دایکندی

Cash دارد. هر هفته Cash Count می‌کنی و با Cash Book مقایسه می‌کنی. اگر تفاوت باشد، باید بررسی شود. دفتر ولایتی SO در نیلی ۲۰,۰۰۰ افغانی

۵.۸ حسابرسی (Audit)

مفهوم ساده

ارائه دهند MoPH کنند و راپور آن را به Audit ها موظف هستند سالانه NGO. یعنی بررسی مالی Audit

نوع	کی؟	توسط کی؟
داخلی (Internal)	در جریان کار	تیم داخلی سازمان
خارجی (External)	سالانه	شرکت Audit خارجی
دونر	در صورت ضرورت	دونر

مثال از دایکندی

را بررسی می‌کند. تو باید تمام اسناد را آماده داشته باشی – فاکتورها، رسیدها، تصفیه Advance ها، راپورها. یک شرکت Audit خارجی می‌آید و اسناد مالی دفتر SO دایکندی

برای امتحان

آسان است Audit، بررسی مالی؛ اگر اسناد کامل باشد = Audit

۵.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

بودجه ماهانه دوا: ۳۰,۰۰۰ افغانی؛ مصرف واقعی: ۳۵,۰۰۰ افغانی. سؤال: Variance چقدر است؟ چه می‌کنی؟

جواب مدل

می‌کنم؛ اگر غیرموجه باشد، توضیح می‌دهم و از تکرار جلوگیری می‌کنم $\text{Variance} = 30,000 - 35,000 = -5,000$ اگر موجه باشد، بودجه ماه بعد را اصلاح دیر رسیده و از جای دیگر خریده‌ایم؟ بعد با دفتر مرکزی صحبت می‌کنم. اگر موجه باشد، بودجه ماه بعد را اصلاح افغانی بیشتر مصرف شده). اول علت را پیدا می‌کنم: آیا قیمت دوا بلند شده؟ آیا مصرف زیاد شده؟ آیا تدارکات افغانی (۵,۰۰۰)

Sample Answer

$\text{Variance} = 30,000 - 35,000 = -5,000$ AFN (over-spent). First, I would investigate the cause: Was there a price increase, increased consumption, or emergency procurement? Then I would discuss with the central office. If justified, I would adjust the next month's budget. If not, I would provide an explanation and take corrective action to prevent recurrence.

۵.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- پلان پولی = Budget.
- مقایسه پلان با واقعیت = Planned vs Actual.
- Variance = Planned – Actual.
- تصفیه = Clearance = پول پیش‌پرداخت؛ Advance.
- اسناد حمایتی – بدون سند، هیچ مصرفی قبول نیست = Supporting Documents.
- بررسی مالی – اسناد را آماده داشته باش = Audit.

فرمول طلایی: $Variance = Planned - Actual$

جواب‌های طلایی فصل پنجم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
چیست؟ Variance	تفاوت بین پلان‌شده و واقعی	The difference between planned and actual.
چیست؟ Advance	پول پیش‌پرداخت	Pre-payment for activities.
چیست؟ Clearance	تصفیه Advance با اسناد	Settling an advance with supporting documents.
چیست؟ Supporting Documents	فاکتور، رسید، قرارداد	Invoices, receipts, contracts.
چیست؟ Audit	بررسی مالی	Financial review.
اگر Variance بزرگ باشد چه می‌کنی؟	را پیدا کن، با دفتر مرکزی صحبت کن علت	Investigate the cause and discuss with the central office.

نکته آخر فصل پنجم

پول امانت است؛ هر افغانی که مصرف می‌شود، باید سند داشته باشد. Advance → مصرف → اسناد → حفظ کن.
تصفیه – این چرخه را

فصل ششم: منابع بشری و اداره

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. روند استخدام را مطابق ToR و پالیسی سازمان اجرا می‌کند.
۲. حاضری، رخصتی و ارزیابی عملکرد را مدیریت می‌کند.
۳. روند اجرای اداری را عادلانه و مستند پیش می‌برد.
۴. اصول PSEA را می‌داند و می‌داند در صورت شک یا شکایت، چطور و به کی گزارش بدهد.

چرا این فصل مهم است؟

مدیریت کندی HR با مردم کار می‌کند - استخدام، حاضری، اجرای اداری، رفع مشکلات. اگر Coordinator را نفهمی، تیم را نمی‌توانی.

۶.۱ استخدام (Recruitment)

مفهوم ساده

یعنی پیدا کردن و استخدام کردن کارمند مناسب Recruitment

شناسایی نیاز → ToR/Job Description

اعلان وظیفه (Vacancy Announcement)

جمع‌آوری CVها → Shortlisting

امتحان + مصاحبه

انتخاب + قرارداد

مثال از دایکندی

می‌شود. اعلان در وبسایت ToR. با دفتر مرکزی هماهنگ می‌کند Coordinator. نیلی نیاز به یک قابله دارد BHC
انتخاب و قرارداد می‌شود Shortlisting، ها جمع می‌شود CV. و کانال‌های محلی نشر می‌شود ACBAR نوشته
انجام می‌شود، امتحان و مصاحبه برگزار می‌شود و قابله

برای امتحان

نیاز = Recruitment → ToR → اعلان → Shortlisting → امتحان/مصاحبه → انتخاب

۶.۲ شرح وظایف (ToR)

مفهوم ساده

وظایف: این کارمند چه کار می‌کند، به کی راپور می‌دهد، چه مهارت‌هایی لازم دارد (Terms of Reference) ToR. عنوان وظیفه، هدف، وظایف اصلی، مهارت‌های لازم، تحصیلات، تجربه و مسئول راپوردهی ToR. یعنی شرح خوب شامل:

نمونه – ToR قابل، BHC نیلی

هدف: ارائه خدمات صحت مادر و طفل در BHC نیلی.

وظایف: ارائه ANC و PNC؛ انجام ولادت طبیعی؛ ارجاع موارد پیچیده به شفاخانه؛ ثبت معلومات در Register. مهارت‌ها: قابل تصدیق‌شده، تجربه ۲ ساله. راپوردهی: به Coordinator ولایتی و مسئول کلینیک.

۶.۳ لیست کوتاه (Shortlisting)

مفهوم ساده

تجربه مطابق، ToR ها. معیارها: تحصیلات مطابق CV یعنی انتخاب کاندیدان واجد شرایط از میان Shortlisting. کامل CV، ToR مهارت‌های مطابق، ToR.

مثال از دایکندی

رد می‌شوند (با دلیل Shortlist دارند و ToR برای وظیفه قابل می‌رسد. ۱۰ نفر تحصیلات و تجربه مطابق CV ۲۰). (می‌شوند؛ ۱۰ نفر دیگر).

۶.۴ مصاحبه (Interview)

مفهوم ساده

یعنی ملاقات با کاندید برای ارزیابی مهارت‌ها، تجربه و مناسب بودن Interview. اگر یک مریض بحرانی بیاید چه می‌کنی؟ چطور با تیم کار می‌کنی؟ اگر مشکلی پیش بیاید چطور حل می‌کنی؟ نمونه سؤالات: تجربه قبلی‌ات چیست؟
مثال مصاحبه
را چک می‌کنم، فوراً به داکتر اطلاع می‌دهم، مریض را برای ارجاع آماده می‌کنم و در Register ثبت می‌کنم. «قابل کاندید پرسیده می‌شود: «اگر یک زن باردار با خونریزی بیاید، چه می‌کنی؟» جواب خوب: «اول علائم حیاتی از یک

۶.۵ حاضری (Attendance)

مفهوم ساده

کارمندان هر روز صبح امضا می‌کنند. Coordinator هر ماه چک می‌کند که Attendance با راپور مطابقت دارد. هر مرکز صحتی یک Attendance Sheet دارد.

حفظ کن

حاضری؛ اگر کارمند حاضر نباشد، خدمات متوقف می‌شود = Attendance

۶.۶ رخصتی (Leave)

مفهوم ساده

انواع رخصتی: رخصتی سالانه، رخصتی مریضی، رخصتی زایمان، رخصتی اضطراری.

مثال از دایکندی

را بررسی کنی؛ جانشین موقت پیدا کنی؛ به PPHD اطلاع بدهی؛ مطمئن شوی که خدمات متوقف نمی‌شود. یک قابله در BHC نیلی درخواست رخصتی زایمان می‌دهد. تو باید: درخواست

۶.۷ ارزیابی عملکرد (Performance)

مفهوم ساده

— هر سال یا هر ۶ ماه. معیارها: کیفیت کار، حاضری، همکاری با تیم، رعایت قوانین Performance Evaluation. یعنی ارزیابی کار کارمند

مثال از دایکندی

آیا راپورها به موقع فرستاده؟ آیا معلومات دقیق است؟ آیا آموزش دیده؟ اگر ضعیف باشد، پلان بهبود می‌سازی. تو عملکرد یک کارمند HMIS را ارزیابی می‌کنی:

۶.۸ اجراات (Disciplinary Process)

مفهوم ساده

تخلف → تحقیق → شنیدن دفاع کارمند

تصمیم (تذکر، جریمه، اخراج)

ثبت در فایل کارمند

مثال از دایکندی

او توضیح می‌خواهی. اگر دلیل موجه نباشد، تذکر کتبی می‌دهی. اگر تکرار شود، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهی. یک کارمند بدون اجازه ۳ روز غایب می‌شود. تو تحقیق می‌کنی، از

برای امتحان

اجرایات باید عادلانه، مستند و مطابق پالیسی باشد.

۶.۹ محرمت (Confidentiality)

مفهوم ساده

یعنی حفظ محرمت معلومات. معلومات مریضان و معلومات کارمندان – همه محرم است Confidentiality

مثال از دایکندی

را به کسی بگویی – نه به شورای قریه، نه به خانواده مریض بدون اجازه. فقط تیم صحتی مربوط دسترسی دارد. یک مریض HIV مثبت در BHC نیلی ثبت شده. تو نباید این معلومات

۶.۱۰ حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی (PSEA)

مفهوم ساده

از استثمار و سوء استفاده جنسی. تمام کارمندان (PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse را رعایت کنند PSEA ها باید اصول NGO یعنی حفاظت

شش اصل اساسی PSEA:

اصول شش‌گانه IASC:

سوء استفاده جنسی از سوی کارمندان بشردوستانه، تخلف سنگین کاری است و موجب اخراج از وظیفه می‌شود. ۱. استثمار و

سال ممنوع است - بدون توجه به سن قانونی یا رضایت محلی. ادعای نادانی در مورد سن، عذر پذیرفته نیست. ۲. فعالیت جنسی با افراد زیر ۱۸

کار یا خدمات در بدل رابطه جنسی - از جمله استفاده از کمک‌هایی که حق مستفیدان است - ممنوع است. ۳. تبادل پول، مال،

اکثر سازمان‌ها این روابط را مطلقاً ممنوع کرده‌اند و استفاده نادرست از مقام و جایگاه برای آن، تخلف است. به شدت منع شده است، زیرا بر عدم توازن قدرت بنا شده و اعتبار کمک بشردوستانه را آسیب می‌زند. در عمل، ۴. روابط جنسی میان کارمندان بشردوستانه و مستفیدان برنامه‌ها

همین سازمان یا سازمان دیگر - شک یا نگرانی داشته باشد، مکلف است آن را از راه‌های رسمی گزارش بدهد. ۵. اگر کارمند بشردوستانه در مورد سوء استفاده یا استثمار جنسی از سوی همکار خود - در

جنسی جلوگیری شود؛ مدیران در همه سطوح مسئولیت ویژه‌ای برای ساختن و حفظ چنین محیطی دارند. ۶. هر کارمند مکلف است محیطی را ایجاد و حفظ کند که از استثمار و سوء استفاده

در سازمان خود: محرمانه را از قبل بشناس و به تیم خود هم معرفی کن - قبل از اینکه حادثه‌ای پیش بیاید. کانال گزارش‌دهی PSEA، نام مسئول PSEA و خط تماس

حفظ کن

عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی. اگر چیزی ببینی یا بشنوی، باید گزارش بدهی. خاموش نشو PSEA =

۶.۱۱ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

یک کارمند در BHC نیلی متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده. سؤال: چه می‌کنی؟

جواب مدل

و صحنه می‌شود. تمام مراحل مستند می‌شود. هیچ تصمیمی بدون تحقیق و مطابق پالیسی گرفته نمی‌شود. تحقیق محرم انجام می‌شود. کارمند موقتاً از کار کنار گذاشته می‌شود تا تحقیق کامل شود. مریض حمایت روانی می‌کنم و به هیچ کس اطلاع نمی‌دهم. فوراً به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم و با مسئول PSEA تماس می‌گیرم. حریمیت حفظ

Sample Answer

First, I would maintain confidentiality and immediately report to the central office and the PSEA focal point. I would ensure the alleged perpetrator is temporarily suspended from duty pending investigation. I would ensure the survivor receives medical and psychosocial support. I would document all actions and ensure the investigation follows organizational policy. No decision would be made without a thorough and fair investigation.

۶.۱۲ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

نیاز = Recruitment → ToR → اعلان → Shortlisting → امتحان/مصاحبه → انتخاب.

• شرح وظایف = ToR

• رخصتی = Leave حاضری؛ Attendance

• ارزیابی عملکرد = Performance

• روند اجراات – عادلانه و مستند = Disciplinary Process

• عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی = PSEA

حمایت کن ← گزارش بده ← اصل طلایی PSEA: ببین

جواب‌های طلایی فصل ششم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
چطور انجام می‌شود؟ Recruitment	نیاز → ToR → اعلان → Shortlisting → مصاحبه → انتخاب	→ Announcement → ToR → Need → Interview → Shortlisting Selection.
چیست؟ ToR	شرح وظایف	Terms of Reference – job description.
اگر کارمند متخلف باشد چه می‌کنی؟	کن، دفاع بشنو، مطابق پالیسی اقدام کن تحقیق	Investigate, hear their side, and act according to policy.
چیست؟ Confidentiality	حفظ محرمت معلومات	Keeping information confidential.
چیست؟ PSEA	حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی	Protection from Sexual Exploitation and Abuse.
اگر PSEA تخلف ببینی چه می‌کنی؟	فوراً گزارش بده – محرمت حفظ کن	Report immediately – maintain confidentiality.

نکته آخر فصل ششم

سرمایه سازمان. اگر تیم را درست مدیریت کنی، خدمات بهتر می‌شود. PSEA = خط سرخ؛ هیچ استثنایی نیست. کارمند =

فصل هفتم: هماهنگی و مدیریت Stakeholderها

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. Stakeholder می‌دانی و نقش هرکدام را می‌دانی.
۲. با MoPH، PPHD، دفتر مرکزی و جامعه - هر کدام با زبان و روش خودش - هماهنگ می‌کنی.
۳. تعارض را می‌شناسی و آن را با شنیدن، بررسی و پیگیری حل می‌کنی.
۴. می‌دانی چه وقت و چطور مشکل را Escalate کنی.

چرا این فصل مهم است؟

باشی Coordinator ها کار کنی، نمی‌توانی Stakeholder هماهنگ‌کننده. اگر نتوانی با = Coordinator

ها کی‌ها اند؟ Stakeholder ۷.۱

مفهوم ساده

یعنی هر کسی که در کار تو تأثیر دارد یا از کار تو تأثیر می‌گیرد Stakeholder

نقش	Stakeholder
تصمیم‌گیری، بودجه، پالیسی	دفتر مرکزی (Central Office)
ریاست صحت عامه ولایت - هماهنگی، نظارت	PPHD
وزارت صحت عامه - پالیسی، معیارها	MoPH
هماهنگی در ساحه	های دیگر NGO
دو نر، هماهنگی	UN Agencies
مشارکت جامعه	شورای صحت
ارائه خدمات	مراکز صحت
دریافت‌کنندگان خدمات	مریضان

مثال از دایکندی

کابل SO ها، شوراها، قریه و دفتر مرکزی BHC، دایکندی، شفاخانه ولایتی PPHD: های تو شامل Stakeholder در.

۷.۲ هماهنگی با PPHD

در جلسات PPHCC اشتراک کنی؛ راپور SO را شریک کنی؛ مشکلات را مطرح کنی؛ از PPHD کمک بخواهی. تو باید:

مثال از دایکندی

— فعالیت‌ها، مشکلات، پلان‌ها SO دایکندی هر ماه جلسه می‌کند. تو باید در آن اشتراک کنی و راپور PPHCC را ارائه بدهی.

۷.۳ هماهنگی با MoPH

سالانه ارائه دهند Audit بدهند؛ MoPH کار کنند؛ راپور ربعوار به BPHS/EPHS ها باید؛ مطابق NGO.

مثال از دایکندی

MoPH، بفرستد. اگر مشکلی باشد MoPH و PPHD در دایکندی باید راپور ربعوار فعالیت‌های صحنی را به SO کند. Audit می‌تواند.

۷.۴ هماهنگی با دفتر مرکزی

تو باید: راپور منظم بفرستی؛ مشکلات را اطلاع بدهی؛ از آنها راهنمایی بخواهی؛ مطابق پالیسی کار کنی.

مثال از دایکندی

بزرگ پیش بیا، تو فوراً به دفتر مرکزی SO در کابل اطلاع می‌دهی. آنها تصمیم می‌گیرند که چه اقدام شود. اگر در دایکندی یک مشکل امنیتی

۷.۵ هماهنگی با جامعه

تو باید: با شورای صحنی جلسه کنی؛ مشکلات جامعه را بشنوی؛ خدمات را مطابق نیاز جامعه هماهنگ کنی.

مثال از دایکندی

تو با شورای قریه جلسه می‌کنی، مشکل را می‌شنوی و با PPHD هماهنگ می‌کنی تا قابله جدید استخدام شود. در یک قریه در ولسوالی اشتراکی، مردم شکایت دارند که قابله در کلینیک نیست.

۷.۶ مدیریت تعارض (Conflict)

مفهوم ساده

طبیعی است؛ مهم این است که چطور مدیریت شود Conflict، یعنی اختلاف نظر یا دعوا. در محیط کار Conflict

نوع	مثال
بین کارمندان	دو کارمند با هم اختلاف دارند
بین سازمان و PPHD	اختلاف در اولویت‌ها
بین سازمان و جامعه	جامعه از خدمات راضی نیست

مثال از دایکندی

مشکل را می‌شنوی، حقیقت را بررسی می‌کنی و راه‌حل ارائه می‌دهی - مثلاً آموزش مجدد در ثبت معلومات. نیلی با هم دعوا می‌کنند - یکی می‌گوید دیگری معلومات را اشتباه ثبت می‌کند. تو هر دو را جداگانه می‌بینی، دو کارمند در BHC

برای امتحان

را خاموش نکن: بشنو، بررسی کن، حل کن، پیگیری کن Conflict

۷.۷ ارتباط (Communication)

مفهوم ساده

راپور، (Meeting) یعنی رد و بدل کردن معلومات - کتبی، شفاهی، رسمی، غیررسمی: جلسه Communication. ایمیل، تماس تلفونی، جلسه غیررسمی، (Report)

مثال از دایکندی

می‌کنی - Communication رسمی. بعد از جلسه، یک ایمیل تأییدی می‌فرستی - Communication کتبی. تو با PPHD مشکل Stock-out دوا در BHC اشتراکی را مطرح

حفظ کن

خوب = واضح + محترمانه + مستند Communication

۷.۸ تشدید (Escalation)

مفهوم ساده

یعنی بردن مشکل به سطح بالاتر - وقتی خودت نمی‌توانی حل کنی Escalation
کی Escalate کنی؟

- مشکل از توان تو بالاتر است
- مشکل فوری است و راه‌حل محلی ندارد
- مشکل امنیتی است
- مشکل مالی بزرگ است

مثال از دایکندی

شهرستان ۲ ماه دوا دریافت نکرده. تو با تدارکات ولایتی پیگیری کردی - جواب نداد. حالا به دفتر مرکزی BHC می‌کنی؛ آنها با تدارکات مرکزی صحبت می‌کنند Escalate

برای امتحان

تلاش = ضعف Escalation - وقتی لازم است، به سطح بالاتر برو. اما اول خودت تلاش کن = Escalation بدون.

۷.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

کیتی شکایت دارد که داکتر زن در کلینیک نیست و زنان نمی‌توانند به داکتر مرد مراجعه کنند. سؤال: چه می‌کنی؟ شورای قریه در ولسوالی

جواب مدل

اطلاع می‌دهم که اقدام در جریان است. به دفتر مرکزی راپور می‌دهم. پیگیری می‌کنم تا داکتر زن استخدام شود. تا داکتر زن جدید استخدام شود. اگر فوری باشد، از کلینیک نزدیک‌تر داکتر زن موقت می‌فرستم. به شورای قریه می‌کنم - آیا داکتر زن اصلاً استخدام شده؟ آیا رخصتی است؟ آیا استعفا داده؟ بعد با PPHD هماهنگ می‌کنم اول با شورای قریه جلسه می‌کنم و مشکل را دقیق می‌شنوم. بعد به کلینیک می‌روم و وضعیت را بررسی

Sample Answer

First, I would meet with the community shura to understand the issue. Then I would visit the facility to verify the situation. I would coordinate with PPHD to recruit a female doctor, arrange a temporary female doctor from a nearby facility if possible, inform the community about the action being taken, report to the central office, and follow up until the position is filled.

۷.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- هر کسی که در کار تأثیر دارد = Stakeholder
- ریاست صحت عامه ولایت - هماهنگی کن = PPHD
- وزارت صحت عامه - پالیسی و معیارها = MoPH
- دفتر مرکزی = مرکز تصمیم‌گیری SO.
- را بشنو، بررسی کن، حل کن Conflict
- وقتی لازم است، به سطح بالاتر برو = Escalation

مستند ← محترمانه ← اصل طلایی Communication: واضح

جواب‌های طلایی فصل هفتم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
کیست؟ Stakeholder	کسی که در کار تأثیر دارد یا تأثیر می‌گیرد هر	Anyone who affects or is affected by the work.

Provincial Public Health Directorate.	ریاست صحت عامه ولایت	چیست؟ PPHD
Listen, verify, resolve, and follow up.	بشنو، بررسی کن، حل کن، پیگیری کن	چطور حل می‌کنی؟ Conflict
When the issue is beyond your capacity.	وقتی مشکل از توان تو بالاتر است	کی می‌کنی؟ Escalation
Clear, respectful, and documented.	واضح، محترمانه، مستند	خوب چه ویژگی دارد؟ Communication
Meet with the shura, listen to issues, coordinate services.	شنیدن مشکلات، هماهنگی خدمات جلسه با شورا،	با جامعه چطور هماهنگ می‌کنی؟

نکته آخر فصل هفتم

PPHD. هماهنگ‌کننده؛ اگر نتوانی هماهنگ کنی، نمی‌توانی کار کنی = MoPH → Coordinator → دفتر مرکزی
→ جامعه – این زنجیر را حفظ کن.

فصل هشتم: سناریوهای واقعی Provincial Coordinator

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. سی سناریوی واقعی کار Coordinator را می‌شناسی و برای هر کدام پلان اقدام داری.
۲. در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار می‌بری: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند ← راپور بده ← پیگیری کن.
۳. جواب دری و انگلیسی هر سناریو را می‌توانی در امتحان و مصاحبه بازگو کنی.
۴. می‌دانی در بحران اول کدام کار را انجام بدهی.

چرا این فصل مهم است؟

فصل ۳۰ سناریوی واقعی دارد - با جواب مدل. قانون: در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار ببر: بفهم در امتحان و مصاحبه، سناریو می‌دهند. این ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← بده راپور ← پیگیری کن

سناریو ۱: Stock-out دوا در BHC نیلی

موقعیت: BHC نیلی دواهای اساسی (Amoxicillin و Paracetamol) تمام کرده؛ ۲۰ مریض در صف است. را چک می‌کنم - چرا تمام شده؟ علت را پیدا می‌کنم. در راپور نظارت مستند می‌کنم. پیگیری می‌کنم تا دوا برسد. می‌خواهم؛ اگر ممکن باشد از BHC نزدیک‌تر دوا قرض می‌گیرم؛ به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. Stock Card اولویت اول = حل فوری. با تدارکات ولایتی تماس می‌گیرم؛ از PPHD کمک

Sample Answer

First, I would address the immediate need by contacting the provincial logistics team and requesting support from PPHD. If possible, I would arrange a loan from a nearby facility. I would inform the central office, investigate the root cause using the stock card, document the findings, and follow up until the medicine is replenished.

سناریو ۲: راپور HMIS ناقص

راپور HMIS ولایت ناقص است - ۱۰ کلینیک راپور نفرستاده‌اند؛ امروز آخرین روز فرستادن به PPHD است. موقعیت:

نبود کارمند؟ مشکل امنیتی؟ اگر ممکن باشد، راپور ناقص را با معلومات موجود می‌فرستم و به HMIS Officer راپور بفرستند PPHD را مسئول می‌کنم که فوراً با ۱۰ کلینیک تماس بگیرد و علت را بپرسد - مشکل تخنیک؟ که راپور تکمیلی بعداً می‌آید. دلیل تأخیر و اقدام را در راپور ماه بعد می‌نویسم. پیگیری می‌کنم که کلینیک‌ها اطلاع می‌دهم.

Sample Answer

I would assign the HMIS Officer to immediately contact the 10 facilities, identify the reasons for delay, and collect the reports. If necessary, I would submit a partial report to PPHD and communicate that the complete report will follow. I would document the reasons and actions taken, and follow up to ensure all facilities submit their reports.

سناریو ۳: مریض TB ثبت نمی‌شود

موقعیت: راپور HMIS نشان می‌دهد BHC نیلی صفر مریض TB دارد - سال گذشته ۱۵ مریض بود. باشد آموزش کوتاه می‌دهم. به PPHD اطلاع می‌دهم؛ در راپور نظارت مستند می‌کنم؛ هفته بعد پیگیری می‌کنم. یا واقعاً مریض نیست؟ اگر ثبت نمی‌شود، به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که ثبت را اصلاح کند؛ اگر لازم به Register TB مراجعه می‌کنم؛ با مسئول TB صحبت می‌کنم: آیا ثبت نمی‌شود

Sample Answer

I would verify the data against the TB register and discuss with the TB focal point. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action is taken, report to PPHD, and follow up to confirm accurate data in the next reporting period.

سناریو ۴: قابل استعفا می‌دهد

موقعیت: قابل BHC نیلی استعفا می‌دهد؛ ولادت‌ها متوقف می‌شود. می‌دهم که اقدام در جریان است. به دفتر مرکزی راپور می‌دهم. پیگیری می‌کنم تا قابل جدید استخدام شود. و درخواست قابل جدید می‌کنم. اگر ممکن باشد، از BHC نزدیک‌تر قابل موقت می‌فرستم. به شورای قریه اطلاع اول علت استعفا را می‌پرسم - آیا قابل حل است؟ اگر نه، فوراً به PPHD اطلاع می‌دهم

Sample Answer

First, I would understand the reason for resignation. If not resolvable, I would immediately inform PPHD and request a replacement. I would arrange a temporary midwife from a nearby facility if possible, inform the community, report to the central office, and follow up until a new midwife is recruited.

سناریو ۵: مشکل امنیتی در راه

موقعیت: در راه BHC اشتراکی مشکل امنیتی است؛ نمی‌توانی نظارت بروی. به تعویق بینداز. از راه‌های دیگر (تلفون، راپور کتبی) معلومات جمع کن. اگر مشکل بزرگ باشد، Escalate کن. اول امنیت خودت و تیم را در نظر بگیر. به PPHD و دفتر مرکزی اطلاع بده. نظارت را

Sample Answer

First, I would prioritize safety. I would inform PPHD and the central office, postpone the visit, and use alternative methods such as phone calls and written reports to collect information. If the issue is significant, I would escalate it to the central office.

سناریو ۶: دوا در زمستان گیر می‌کند

موقعیت: در ماه قوس، دوا برای BHC اشتراکی نفرستاده شده؛ راه‌ها در حال بسته شدن است. کمک می‌خواهم. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. از تجربه درس می‌گیرم – باید از ماه میزان شروع می‌کردم. فوراً با تدارکات تماس می‌گیرم. اگر دوا موجود است، باید فوراً فرستاده شود؛ اگر ممکن نباشد، از PPHD

Sample Answer

I would immediately contact logistics to send the medicine urgently. If not possible, I would request support from PPHD. I would inform the central office and document the lesson learned: winterization planning must start in Mizan, not Qaws.

سناریو ۷: کارمند بدون اجازه غایب

موقعیت: یک کارمند BHC نیلی ۳ روز بدون اجازه غایب است. موجه نباشد، تذکر کتبی می‌دهم. اگر تکرار شود، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. در فایل کارمند ثبت می‌کنم. حضری را چک می‌کنم؛ با کارمند صحبت می‌کنم. اگر دلیل

Sample Answer

I would check attendance records, discuss with the employee, and if the absence is unjustified, issue a written warning. If repeated, I would escalate to the central office and document it in the employee's file.

سناریو ۸: شورای قریه شکایت دارد

موقعیت: شورای قریه در کیتی شکایت دارد که خدمات کلینیک ضعیف است. واقعی است، با PPHD هماهنگ می‌کنم؛ به شورا اطلاع می‌دهم که اقدام در جریان است؛ پیگیری می‌کنم. با شورا جلسه می‌کنم؛ شکایت را دقیق می‌شنوم؛ به کلینیک می‌روم و وضعیت را بررسی می‌کنم. اگر مشکل

Sample Answer

I would meet with the shura, listen to their concerns, visit the facility to verify, coordinate with PPHD for corrective action, inform the community, and follow up.

سناریو ۹: دو مشکل همزمان – دوا و راپور

صبح تماس می‌گیرند: دوا در نیلی تمام شده؛ همزمان HMIS Officer می‌گوید راپور امروز آخرین روز است. موقعیت: راپور را جمع کند؛ خودم مشکل دوا را حل می‌کنم. بعد از حل دوا، پیگیری راپور را چک می‌کنم. اولویت اول = دوا (زندگی مردم). HMIS Officer

Sample Answer

I would prioritize the medicine stock-out because patient lives are at risk. I would assign the HMIS Officer to collect the report while I address the medicine issue. After resolving the stock-out, I would follow up on the report.

سناریو ۱۰: PPHD در جلسه سخت‌گیری می‌کند

موقعیت: در جلسه PPHCC، رئیس PPHD از SO شکایت دارد که راپور دیر می‌فرستد. ماه بعد راپور به‌موقع برسد. در جلسه خاموش نمی‌نشینم – مشکل را واضح می‌گویم و راه‌حل پیشنهاد می‌کنم. – نبود کارمند HMIS در یک ولسوالی. اقدام اصلاحی پیشنهاد می‌کنم – آموزش کارمند موجود. تعهد می‌دهم که عذر می‌خواهم و علت را توضیح می‌دهم

Sample Answer

I would apologize, explain the reason (lack of HMIS staff in one district), propose corrective action (training existing staff), and commit to timely reporting next month. I would not remain silent – I would clearly present the issue and propose a solution.

سناریو ۱۱: دوا منقضی می‌شود

موقعیت: Stock Card نشان می‌دهد ۱۰۰ دانه Amoxicillin در BHC نیلی در ماه جوزا منقضی می‌شود. مرکز دیگر می‌فرستم. به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که موجودی را به‌روز نگه دارد. در راپور مستند می‌کنم. موجودی و تاریخ انقضا را چک می‌کنم. اگر ممکن باشد، دوا را قبل از انقضا مصرف می‌کنم یا به

Sample Answer

I would check stock and expiry dates. If possible, I would redistribute the medicine before expiry. I would instruct the facility to maintain accurate stock records and document the action taken.

سناریو ۱۲: استخدام قابله – مشکل Shortlisting

موقعیت: برای وظیفه قابله در نیلی، ۲۰ CV می‌رسد؛ فقط ۳ نفر واجد شرایط هستند. را انتخاب می‌کنم. اگر تعداد کم باشد، اعلان را دوباره نشر می‌کنم. اگر فوری باشد، از ToR را مطابق Shortlisting. دیگر کمک می‌خواهم NGO یا PPHD انجام می‌دهم و ۳ نفر واجد شرایط

Sample Answer

I would conduct shortlisting according to the ToR, select the 3 qualified candidates, and if the number is insufficient, re-advertise. If urgent, I would request support from PPHD or another NGO.

سناریو ۱۳: تصفیه Advance دیر می‌شود

موقعیت: یک کارمند Advance گرفته برای سفر نظارتی؛ ۲ هفته گذشته و تصفیه نکرده. مشکل مالی دارد، با دفتر مرکزی صحبت می‌کنم. مطابق پالیسی، Advance باید در زمان مشخص تصفیه شود. با کارمند صحبت می‌کنم و علت تأخیر را می‌پرسم. اگر اسناد ندارد، کمک می‌کنم جمع کند. اگر

Sample Answer

I would discuss with the employee to understand the delay. If documents are missing, I would help collect them. If there is a financial issue, I would consult the central office. According to policy, advances must be cleared within the specified timeframe.

سناریو ۱۴: Audit می‌آید

موقعیت: یک شرکت Audit خارجی می‌آید و اسناد مالی دفتر ولایتی را بررسی می‌کند. می‌کنم. هر سؤالی که Audit دارد، صادقانه جواب می‌دهم. اگر مشکلی باشد، فوراً به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. تمام اسناد مالی را آماده می‌کنم – فاکتورها، رسیدها، تصفیه Advance ها، راپورها. با تیم مالی هماهنگ

Sample Answer

I would ensure all financial documents are ready – invoices, receipts, advance clearances, and reports. I would coordinate with the finance team, answer audit questions honestly, and immediately inform the central office of any issues.

سناریو ۱۵: زمستان – آمادگی

موقعیت: در ماه میزان هستی؛ باید برای زمستان آماده شوی. با تدارکات هماهنگ می‌کنم؛ ذخیره احتیاطی می‌سازم؛ به PPHD اطلاع می‌دهم؛ پلان زمستانی می‌نویسم. دوا و تجهیزات را برای BHC های دورافتاده آماده می‌کنم؛ سوخت و گرمی‌کننده تهیه می‌کنم؛

Sample Answer

I would prepare medicines and supplies for remote facilities, arrange fuel and heating, coordinate with logistics, build safety stock, inform PPHD, and document a winterization plan.

سناریو ۱۶: مریض شکایت دارد

موقعیت: یک مریض شکایت دارد که در BHC نیلی بدرفتاری شده. تخلف باشد، مطابق پالیسی اقدام می‌کنم؛ به مریض اطلاع می‌دهم که پیگیری می‌شود؛ در راپور مستند می‌کنم. شکایت را می‌شنوم؛ محرمیت حفظ می‌کنم؛ با مسئول کلینیک صحبت می‌کنم؛ حقیقت را بررسی می‌کنم. اگر

Sample Answer

I would listen to the complaint, maintain confidentiality, discuss with the facility in-charge, verify the facts, take action according to policy, inform the patient, and document the case.

سناریو ۱۷: HMIS Reporting Rate پایین

موقعیت: Reporting Rate ولایت ۷۰٪ است؛ باید بالا برود.

آموزش می‌دهم؛ اگر مشکل امنیتی است، به PPHD اطلاع می‌دهم. پلان Action می‌سازم و پیگیری می‌کنم. – کدام کلینیک‌ها نفرستاده‌اند و چرا؟ اگر مشکل تخنیکی است، کمک تخنیکی می‌کنم؛ اگر نبود کارمند است، علت را پیدا می‌کنم

Sample Answer

I would identify which facilities are not reporting and why. If it is a technical issue, I would provide technical support. If it is a staffing issue, I would provide training. If it is a security issue, I would inform PPHD. I would create an action plan and follow up.

سناریو ۱۸: موتر خراب می‌شود

موقعیت: موتر دفتر ولایتی برای نظارت خراب شده؛ سفر نظارتی فردا است.

فوری باشد، کرایه می‌کنم؛ اگر نه، به تعویق می‌اندازم و به کلینیک اطلاع می‌دهم. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. گزینه‌ها را بررسی می‌کنم: موتر کرایه می‌کنم؟ با PPHD هماهنگ کنم؟ سفر را به تعویق بیندازم؟ اگر سفر

Sample Answer

I would explore options: rent a vehicle, coordinate with PPHD, or postpone. If urgent, I would rent. If not, I would reschedule and inform the facility and central office.

سناریو ۱۹: دو کارمند با هم دعوا می‌کنند

موقعیت: دو کارمند در BHC نیلی با هم دعوا می‌کنند.

را بررسی می‌کنم؛ راه‌حل ارائه می‌دهم. اگر لازم باشد، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. در راپور مستند می‌کنم. هر دو را جداگانه می‌بینم؛ مشکل را می‌شنوم؛ حقیقت

Sample Answer

I would meet with each employee separately, listen to both sides, verify the facts, provide a solution, inform the central office if necessary, and document the case.

سناریو ۲۰: PPHD درخواست معلومات فوری دارد

موقعیت: PPHD می‌خواهد معلومات فوری در مورد یک کلینیک بدهی؛ تو در ساحه هستی.

به PPHD می‌فرستم. اگر نتوانم فوراً جمع کنم، به PPHD اطلاع می‌دهم که تا چند ساعت دیگر می‌فرستم. با کلینیک تماس می‌گیرم؛ معلومات را جمع می‌کنم؛

Sample Answer

I would contact the facility, collect the information, and send it to PPHD. If I cannot collect it immediately, I would inform PPHD of a realistic timeline.

سناریو ۲۱: دوا در راه گم می‌شود

موقعیت: دوا برای BHC اشتراکی فرستاده شد، اما به مقصد نرسید.
شده، به PPHD و دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم؛ دواي جديد درخواست می‌کنم؛ در راپور حادثه‌ای مستند می‌کنم.
با تدارکات و ترانسپورت تماس می‌گیرم و پیگیری می‌کنم دوا کجاست. اگر گم

Sample Answer

I would contact logistics and transport to trace the shipment. If lost, I would inform PPHD and the central office, request replacement, and document an incident report.

سناریو ۲۲: کارمند جدید آموزش می‌خواهد

موقعیت: یک کارمند جدید HMIS استخدام شده؛ آموزش ندارد.
باشد، آموزش آنلاین DHIS2 ترتیب می‌دهم. خودم هم آموزش اولیه می‌دهم. پیگیری می‌کنم که آموزش دیده.
آموزش را با PPHD یا دفتر مرکزی هماهنگ می‌کنم. اگر ممکن

Sample Answer

I would coordinate training with PPHD or the central office. If possible, I would arrange DHIS2 online training. I would also provide basic orientation and follow up to ensure training is completed.

سناریو ۲۳: دواي منقضی – دفع

موقعیت: Stock Card نشان می‌دهد ۵۰ دانه دواي منقضی در BHC نیلی موجود است.
ثبت می‌کنم؛ به PPHD اطلاع می‌دهم. علت انقضا را بررسی می‌کنم – آیا مصرف کم بوده یا سفارش زیاد؟
دواي منقضی را جدا می‌کنم؛ مطابق طرزالعمل دفع می‌کنم؛ در Stock Card

Sample Answer

I would separate expired medicines, dispose of them according to procedure, record it in the stock card, inform PPHD, and investigate the cause (low consumption or over-ordering).

سناریو ۲۴: مریض بحرانی – ارجاع

موقعیت: یک مریض بحرانی در BHC نیلی است؛ باید به شفاخانه ولایتی ارجاع شود.
کند؛ با شفاخانه ولایتی هماهنگ می‌کنم؛ اگر ترانسپورت لازم باشد، ترتیب می‌دهم؛ در Register ثبت می‌کنم.
مسئول کلینیک را هدایت می‌کنم که مریض را برای ارجاع آماده

Sample Answer

I would instruct the facility to prepare the patient for referral, coordinate with the provincial hospital, arrange transport if needed, and document it in the register.

سناریو ۲۵: راپور ماهوار - آمار اشتباه

ماهوار یک کلینیک آمار اشتباه دارد - تعداد مریضان OPD ۵۰۰ نوشته شده، اما Register ۳۵۰ نشان می‌دهد. موقعیت: راپور

اگر آمار اشتباه است، اصلاح می‌کنم؛ به HMIS Officer اطلاع می‌دهم؛ آموزش مجدد می‌دهم؛ پیگیری می‌کنم. با مسئول کلینیک تماس می‌گیرم و تفاوت را توضیح می‌دهم؛ Register را چک می‌کنم؛

Sample Answer

I would contact the facility, explain the discrepancy, verify the register, correct the report, inform the HMIS Officer, provide refresher training, and follow up.

سناریو ۲۶: بودجه تمام می‌شود

موقعیت: بودجه ماهانه تمام شده، اما یک فعالیت مهم باقی مانده.

است، از دفتر مرکزی درخواست بودجه اضافی می‌کنم؛ اگر نه، به ماه بعد موکول می‌کنم. در راپور مستند می‌کنم. اولویت را بررسی می‌کنم - آیا فعالیت فوری است؟ اگر فوری

Sample Answer

I would assess the priority. If urgent, I would request additional budget from the central office. If not, I would postpone to next month and document it.

سناریو ۲۷: کارمند PSEA تخلف می‌کند

موقعیت: یک کارمند متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده.

می‌شود؛ مریض حمایت روانی و صحت می‌شود؛ تحقیق محرم انجام می‌شود؛ مطابق پالیسی اقدام می‌شود. محرمانه حفظ می‌کنم؛ فوراً به دفتر مرکزی و مسئول PSEA اطلاع می‌دهم؛ کارمند موقتاً از کار کنار گذاشته

Sample Answer

I would maintain confidentiality, immediately report to the central office and PSEA focal point, suspend the employee pending investigation, ensure the survivor receives support, and follow policy for investigation and action.

سناریو ۲۸: شورای قریه نمی‌خواهد واکسین بزند

موقعیت: شورای قریه در یک ولسوالی مخالف واکسین است.

از بزرگان و علمای قریه کمک می‌خواهم؛ اگر لازم باشد، از PPHD کارمند آگاهی‌دهی می‌فرستم؛ پیگیری می‌کنم. با شورا جلسه می‌کنم؛ نگرانی‌شان را می‌شنوم؛ معلومات درست در مورد واکسین می‌دهم؛

Sample Answer

I would meet with the shura, listen to their concerns, provide accurate information about vaccination, engage community elders and religious leaders, request health education support from PPHD if needed, and follow up.

سناریو ۲۹: زلزله - پاسخ فوری

موقعیت: در دایکندی زلزله شده؛ مراکز صحتی آسیب دیده.

خدمات موقت ترتیب می‌دهم؛ دوا و تجهیزات فوری می‌فرستم؛ در راپور حادثه‌ای مستند می‌کنم؛ پیگیری می‌کنم. فوراً به دفتر مرکزی و PPHD اطلاع می‌دهم؛ وضعیت مراکز صحتی را ارزیابی می‌کنم؛ اگر آسیب دیده،

Sample Answer

I would immediately inform the central office and PPHD, assess the situation, arrange temporary services if damaged, dispatch emergency supplies, document an incident report, and follow up.

سناریو ۳۰: Coordinator جدید - انتقال وظیفه

موقعیت: تو Coordinator جدید هستی؛ باید از Coordinator قبلی وظیفه را تحویل بگیری.

اسناد مالی؛ بازدید از مراکز صحتی؛ جلسه با PPHD؛ جلسه با تیم؛ شناسایی مشکلات فوری؛ پلان کاری ۳۰ روزه. ملاقات با Coordinator قبلی؛ گرفتن تمام اسناد - راپورها، Stock Cards، فایل‌های HR،

Sample Answer

I would meet with the outgoing coordinator, collect all documents (reports, stock cards, HR files, financial records), visit health facilities, meet with PPHD and the team, identify urgent issues, and create a 30-day work plan.

۸.۳۱ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- در هر سناریو، اولویت اول = زندگی مردم.
- فوراً حل کن، علت را پیدا کن، پیگیری کن = Stock-out.
- ناقص = علت را پیدا کن، جمع کن، پیگیری کن = HMIS.
- مشکل HR = عادلانه، مستند، مطابق پالیسی.
- مشکل مالی = علت را پیدا کن، با دفتر مرکزی صحبت کن.
- عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی = PSEA.

راپور بده ← مستند کن ← اقدام کن ← اولویت بده ← بررسی کن ← هفت کلمه طلایی در هر سناریو: بفهم پیگیری کن ←

جواب‌های طلایی فصل هشتم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
--------------	------------------	-------------------------

Solve immediately, find the cause, and follow up.	حل کن، علت را پیدا کن، پیگیری کن فوراً	چطور حل می‌کنی؟ Stock-out
Identify the cause, collect, and follow up.	علت را پیدا کن، جمع کن، پیگیری کن	ناقص چطور حل می‌کنی؟ HMIS
Maintain confidentiality, report, and investigate.	حفظ کن، گزارش بده، تحقیق کن محرمانه	تخلف چطور مدیریت می‌کنی؟ PSEA
Prioritize – patient lives first.	اولویت بده – زندگی مردم اول	اگر دو مشکل همزمان باشد؟
When the issue is beyond your capacity.	وقتی مشکل از توان تو بالاتر است	کی می‌کنی؟ Escalation
Collect, report, and follow up.	جمع کن، راپور بده، پیگیری کن	راپور ناقص چطور حل می‌کنی؟

نکته آخر فصل هشتم

در امتحان، سناریو می‌دهند – هفت کلمه طلایی را به کار ببر: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن

فصل نهم: Shuhada Organization را بشناس

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. تاریخچه، مأموریت، ارزش‌ها و ساختار Shuhada Organization را توضیح می‌دهی.
۲. فعالیت‌های صحتی SO در دایکندی را می‌شناسی.
۳. مسئولیت‌های این بست را در ساختار SO جای می‌دهی.
۴. برای پرسش‌های مصاحبه در باره SO، جواب آماده داری.

چرا این فصل مهم است؟

نمی‌توانی جواب بدهی. توجه: این فصل فقط معلومات تأییدشده از منابع رسمی SO را شامل می‌شود. در مصاحبه، از SO می‌پرسند. اگر نشناسی،

۹.۱ تاریخچه

مفهوم ساده

گذاشته شد؛ اولین مرکز آن شفاخانه‌ای برای زنان و اطفال افغان پناهنده بود (Shuhada Organization (SO). در سال ۱۹۸۹ توسط داکتر سیما سمر در کویت، پاکستان بنیان

چرا تأسیس شد؟

باروری برای زنان و اطفال افغان را حل کند. در آن زمان، زنان افغان به خدمات صحتی دسترسی نداشتند؛ SO برای آنها شفاخانه و مکتب ساخت SO تأسیس شد تا عدم وجود کامل مراقبت‌های صحتی

توسعه:

آموزش، کمک‌های بشردوستانه، توانمندسازی اقتصادی زنان، حفاظت از اطفال، حقوق بشر و ظرفیت‌سازی. بعد از تأسیس، فعالیت‌های SO به بخش‌های دیگر گسترش یافت:

ولایات تحت پوشش:

در ولایات مرکزی و همجوار افغانستان – از جمله دایکندی، بامیان، غزنی، غور، وردک و کابل – فعالیت دارد SO

دستاوردها

زنان مستفید شده‌اند ۳۸۷۰ طفل حمایت شده‌اند • مجموع: ۶.۳ میلیون نفر از پروژه‌های SO مستفید شده‌اند
مستفید شده‌اند ۳۰,۹۲۱ نفر از ظرفیت‌سازی مستفید شده‌اند ۷,۶۳۴ نفر از توانمندسازی اقتصادی
شده‌اند ۱.۵ میلیون نفر از خدمات حقوق بشر مستفید شده‌اند ۲۲۶,۰۳۸ نفر از کمک‌های بشردوستانه
۵.۸ میلیون نفر از خدمات صحتی مستفید

۹.۲ مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

مأموریت (Mission):

اقتصادی زنان. شعار مشترک SO: Working for a better tomorrow – کار برای فردای بهتر. «ارائه خدمات با کیفیت خوب در بخش‌های صحت، آموزش و توانمندسازی»

چشم‌انداز (Vision):

طریق ارائه خدمات با کیفیت بالا مطابق اصول حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، صلح و عدم تبعیض SO «می‌خواهد یک جامعه آگاه، مرفه و صحتی در افغانستان ببیند - از

ارزش‌ها (Values):

شفافیت (Transparency) • پاسخگویی (Accountability) • حساسیت جنسیتی (Gender Sensitivity)

• حرفه‌ای‌بودن (Professionalism) • تعالی (Excellence)

حفظ کن

Working for a better tomorrow | ارزش‌ها: شفافیت، پاسخگویی، حساسیت جنسیتی، حرفه‌ای‌بودن، تعالی
مأموریت: صحت، آموزش، توانمندسازی زنان | شعار:

۹.۳ ساختار سازمانی

یک ساختار دموکراتیک دارد SO

نقش	نهاد
تصمیم‌گیری عالی	Board of Directors (BoD)
مدیریت اجرایی	Management Board
مدیر اجرایی عمومی	General Executive Director
اجرای پروژه‌ها در ولایات	دفاتر ولایتی

چهار دپارتمان عملی دارد SO

• صحت (Health) • آموزش (Education)

اقتصادی زنان (Women Economic Empowerment) • کمک‌های بشردوستانه (Humanitarian Aid)
• توانمندسازی

۹.۴ فعالیت‌های صحتی SO در دایکندی

در دایکندی فعال است - به شمول ولسوالی‌های نیلی، اشتدرلی، شهرستان و کیتی SO

پروژه‌های اخیر در دایکندی:

(Chuchan) در ولسوالی شهرستان - با هزینه ۳۵,۰۰۰ دالر، با مشارکت جامعه (۲۵,۰۰۰ دالر از جامعه)
• مرکز صحتی چچن (Health Center)

در ولسوالی اشتدرلی - افتتاح در سال ۲۰۲۳ با حمایت مالی (HCS Help Committee Schaffhausen)
• مرکز صحتی کورگا (Korga Health Sub-Center)

• مرکز صحتی شیلان کورگا در ولسوالی اشتدرلی - با هزینه ۴۰,۰۰۰ دالر

مثال از دایکندی

راپور بگیری، مشکلات را حل کنی و با Coordinator دارد. تو Health Post و BHC در دایکندی مراکز صحتی SO هماهنگ کنی PPHD این مراکز هستی: باید نظارت کنی،

۹.۵ فرهنگ سازمانی SO

یک سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقل است. فرهنگ سازمانی آن شامل SO

- تعهد به کیفیت: خدمات با کیفیت بالا
- تمرکز بر زنان و اطفال: اولویت اصلی
- مشارکت جامعه: جامعه در پروژه‌ها شریک است
- هماهنگی با حکومت: کار با MoPH و PPHD
- پاسخگویی: راپور منظم به MoPH و دونه‌ها

مثال از دایکندی

در پروژه مرکز صحتی چچن، جامعه ۲۵,۰۰۰ دالر کمک کرد. این نشان می‌دهد که SO به مشارکت جامعه باور دارد.

۹.۶ مسئولیت‌های این بست (Provincial Coordinator)

مسئولیت	شرح
نظارت بر پروژه‌های SO	اطمینان از تطبیق مطابق پلان
هماهنگی با PPHD	جلسات، راپور، پیگیری
مدیریت تیم ولایتی	حاضری، عملکرد، HR
راپوردهی به دفتر مرکزی	ماهوار، ربعوار
مدیریت تدارکات و مالی	پیگیری دوا، بودجه
ارتباط با جامعه	شوراها، بزرگان
حفاظت از PSEA	رعایت اصول PSEA

مثال از دایکندی

تیم ولایتی از تو راهنمایی می‌خواهد؛ جامعه از تو خدمات می‌خواهد. تو همه این‌ها را هماهنگ می‌کنی. دفتر مرکزی SO در کابل از تو راپور ماهوار می‌خواهد؛ PPHD دایکندی از تو راپور فعالیت‌ها می‌خواهد؛

۹.۷ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

در ۱۹۸۹ توسط داکتر سیما سمر بنیان گذاشته شد SO •

• مأموریت: صحت، آموزش، توانمندسازی زنان.

• شعار: Working for a better tomorrow.

• ارزش‌ها: شفافیت، پاسخگویی، حساسیت جنسیتی، حرفه‌ای بودن، تعالی.

• در دایکندی، بامیان، غزنی و کابل فعال است SO

• در ولایت - هماهنگی، نظارت، راپوردهی SO نماینده = Coordinator

جملات طلایی برای مصاحبه

در ۱۹۸۹ تأسیس شده و بر صحت، آموزش و توانمندسازی زنان تمرکز دارد. «من به ارزش‌های SO»
 بین دفتر مرکزی «Coordinator =» «شفافیت، پاسخگویی و حساسیت جنسیتی - باور دارم - SO
 «.کلینیک‌ها و جامعه، PPHD، حلقه وصل

جواب‌های طلایی فصل نهم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
کی تأسیس شد؟ SO	۱۹۸۹ - توسط داکتر سیما سمر	۱۹۸۹, founded by Dr. Sima Samar.
مأموریت SO چیست؟	صحت، آموزش، توانمندسازی زنان	Health, education, and women economic empowerment.
شعار SO چیست؟	Working for a better tomorrow	Working for a better tomorrow.
ارزش‌های SO چیست؟	شفافیت، پاسخگویی، حساسیت جنسیتی، حرفه‌ای بودن، تعالی	Transparency, accountability, gender sensitivity, professionalism, excellence.
در کدام ولایات فعال است؟ SO	بامیان، غزنی، غور، وردک و کابل دایکندی،	Daykundi, Bamyan, Ghazni, Ghor, Wardak and Kabul.
چه مسئولیتی دارد؟ SO Coordinator	نظارت، راپوردهی، مدیریت تیم هماهنگی،	Coordination, monitoring, reporting, team management.

نکته آخر فصل نهم

نشان بده SO در دایکندی هستی؛ ارزش‌های SO سازمان صحت، آموزش و توانمندسازی زنان. تو نماینده SO =
 را در کارت

فصل دهم: شبیه‌سازی کامل امتحان و مصاحبه

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. سه آزمون آزمایشی کامل را با وقت‌گیری حل می‌کنی.
۲. جواب‌های نمونه دري و انگلیسی را با جواب‌های خودت مقایسه می‌کنی.
۳. در مصاحبه، خودت را معرفی می‌کنی و برای سؤال‌های سناریویی و PSEA آماده‌ای.
۴. نقاط ضعف خودت را می‌شناسی و همان بخش کتاب را دوباره می‌خوانی.

چرا این فصل مهم است؟

این فصل سه Mock Exam کامل دارد. اگر این سه را تمرین کنی، برای امتحان واقعی آماده‌ای.

آزمون آزمایشی ۱

بخش الف: سؤالات چند گزینه‌ای (۱۰) – MCQ سؤال

اولویت اول در کار چیست؟ Coordinator ۱.

الف) راپوردهی به دفتر مرکزی

• ب) جلسات PPHD

• ج) زندگی مردم و تداوم خدمات اساسی

• د) تدارکات

جواب: ج

چه فرق دارد؟ Risk با Issue ۲.

الف) Risk قبلاً اتفاق افتاده، Issue ممکن است بیفتد

• ب) Risk ممکن است بیفتد، Issue قبلاً اتفاق افتاده

• ج) هر دو یک چیز هستند

• د) Risk مالی است، Issue صحی

جواب: ب

چیست؟ AMC ۳.

Average Monthly Consumption (الف)

• ب) Annual Medical Cost

• ج) Afghanistan Medical Council

• د) Advanced Management Course

جواب: الف

چطور محاسبه می‌شود؟ Reorder Point ۴.

الف) AMC + زمان تحویل

• ب) AMC زمان تحویل + ذخیره احتیاطی

• ج) موجودی مصرف

• د) AMC ۲

جواب: ب

۵. HGIS Reporting Rate باید چقدر باشد؟

الف) ۵۰٪

• ب) ۷۰٪

• ج) بالای ۹۵٪

• د) ۱۰۰٪

جواب: ج

۶. Variance چیست؟

الف) Planned + Actual

• ب) Planned - Actual

• ج) Actual Planned

• د) Actual Planned

جواب: ب

۷. PSEA چند اصل اساسی دارد؟

الف) ۳

• ب) ۴

• ج) ۵

• د) ۶

جواب: د

۸. کی تأسیس شد؟ SO

الف) ۱۹۷۹

• ب) ۱۹۸۹

• ج) ۲۰۰۱

• د) ۲۰۰۵

جواب: ب

۹. BPHS چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

الف) خدمات شفاخانه‌ای

• ب) خدمات صحت اولیه

• ج) خدمات تخصصی

• د) خدمات جراحی

جواب: ب

۱۰. Incident Report کی باید فرستاده شود؟

الف) یک هفته بعد

• ب) یک ماه بعد

• ج) همان روز

• د) در راپور ماهوار

جواب: ج

بخش ب: سؤالات کوتاه – ۵ سؤال

۱. Work Plan خوب چه ویژگی دارد؟

جواب: واضح، قابل اندازه‌گیری، مسئول مشخص، زمان مشخص.

۲. Monitoring با Evaluation چه فرق دارد؟

جواب: Monitoring در جریان کار است؛ Evaluation بعد از تمام شدن.

۳. Executive Summary چگونه بنویسی؟

جواب: نتیجه اول، توضیح بعد – نصف صفحه.

۴. Supporting Documents چیست؟

جواب: فاکتور، رسید، قرارداد – اسنادی که ثابت می‌کند پول درست مصرف شده.

۵. Escalation کی می‌کنی؟

جواب: وقتی مشکل از توان تو بالاتر است.

بخش ج: سناریو – ۱ سؤال

تمرین کوتاه

نشان می‌دهد که BHC نیلی در ماه گذشته صفر مریض TB داشته – سال گذشته ۱۵ مریض بود. چه می‌کنی؟
تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. راپور HMIS

جواب مدل

کند؛ آموزش کوتاه می‌دهم؛ به PPHD اطلاع می‌دهم؛ در راپور نظارت مستند می‌کنم؛ هفته بعد پیگیری می‌کنم.
آیا ثبت نمی‌شود یا واقعاً مریض نیست؟ اگر ثبت نمی‌شود، به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که ثبت را اصلاح
اول با Register TB مراجعه می‌کنم؛ با مسئول TB صحبت می‌کنم –

Sample Answer

First, I would verify the data against the TB register. I would discuss with the TB focal point to determine if it is a recording issue. If so, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action, document findings, report to PPHD, and follow up.

بخش د: محاسبه - ۱ سؤال

AMC یک دوا ۲۰۰ دانه است؛ زمان تحویل = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه. Reorder Point چقدر است؟ محاسبه.

جواب: $\text{Reorder Point} = 200 \times 1 + 400 = 600$ دانه

آزمون آزمایشی ۲

بخش الف: ۱۰ - MCQ سؤال

۱. کی ساخته شد؟ BPHS

الف) ۱۹۸۹

ب) ۲۰۰۱

ج) ۲۰۰۳

د) ۲۰۰۵

جواب: ج

۲. چیست؟ DHIS2

الف) سیستم مالی

ب) سیستم معلومات صحی دیجیتال

ج) سیستم HR

د) سیستم تدارکات

جواب: ب

۳. باید کی تصفیه شود؟ Advance

الف) هر وقت

ب) در زمان مشخص

ج) بعد از یک سال

د) تصفیه لازم نیست

جواب: ب

۴. شعار SO چیست؟

الف) Health for All

ب) Working for a better tomorrow

ج) Together We Can

د) Hope for Afghanistan

جواب: ب

۵. اصل اول چیست؟ PSEA

الف) محرریت

- ب) عدم تحمل مطلق
- ج) گزارش الزامی
- د) حمایت از قربانی

جواب: ب

چيست؟ ۶. Stock Card

الف) کارت بانکی

- ب) کارت ثبت موجودی دوا
- ج) کارت حاضری
- د) کارت مریض

جواب: ب

چيست؟ ۷. PPHCC

الف) یک NGO

- ب) کمیته هماهنگی صحتی ولایت
- ج) یک شفاخانه
- د) یک برنامه MoPH

جواب: ب

چيست؟ ۸. Physical Count

الف) شمارش فیزیکی موجودی

- ب) شمارش مریضان
- ج) شمارش کارمندان
- د) شمارش پول

جواب: الف

به کی راپور می دهد؟ ۹. Coordinator

الف) فقط PPHD

- ب) فقط دفتر مرکزی
- ج) PPHD و دفتر مرکزی
- د) فقط جامعه

جواب: ج

کی شروع می شود؟ ۱۰. Winterization

الف) قوس

- ب) جدی
- ج) میزان

۰ د) حمل

جواب: ج

بخش ب: سؤالات کوتاه - ۵ سؤال

برای چند نفر است؟ BHC ۱.

جواب: برای هر ۱۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰ نفر (در ساحات بسیار دور، کمتر از ۱۵,۰۰۰ نفر).

چطور محاسبه می‌شود؟ Variance ۲.

جواب: Planned - Actual.

شامل چه بخش‌هایی است؟ Incident Report ۳.

جواب: تاریخ، مکان، شرح حادثه، افراد متأثر، اقدام فوری، اقدام بعدی.

چه ستون‌هایی دارد؟ Action Plan ۴.

جواب: مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص موفقیت.

تخلف چطور گزارش می‌شود؟ PSEA ۵.

جواب: فوراً به دفتر مرکزی و مسئول PSEA - محرمانه حفظ می‌شود.

بخش ج: سناریو - ۱ سؤال

تمرین کوتاه

هستی. در ماه قوس هستی. BHC اشتراکی دوا دریافت نکرده و راه‌ها در حال بسته شدن است. چه می‌کنی؟
تو Coordinator ولایت دایکندی

جواب مدل

کمک می‌خواهم. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. از تجربه درس می‌گیرم - باید از ماه میزان شروع می‌کردم.
فوراً با تدارکات تماس می‌گیرم. اگر دوا موجود است، باید فوراً فرستاده شود؛ اگر ممکن نباشد، از PPHD

Sample Answer

I would immediately contact logistics to send the medicine urgently. If not possible, I would request support from PPHD. I would inform the central office and document the lesson learned: winterization planning must start in Mizan, not Qaws.

بخش د: راپور نویسی - ۱ سؤال

۴ BHC؛ ۸۵٪ HMIS Reporting Rate؛ ۸۰٪ Drug Availability؛ ۳ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند.
سؤال. راپور ماهوار بنویس. معلومات: نظارت از

Drug مشکلات: ۳ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند. ۵. پلان آینده: پیگیری Stock Card تا ۱۰ ثور. ۴ BHC در ولسوالی‌های نیلی و شهرستان. ۳. نتایج: ۸۵٪ HMIS Reporting Rate؛ ۸۰٪ Drug Availability؛ ۴. فعالیت‌ها: نظارت از این راپور فعالیت‌های صحنی ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵ پوشش می‌دهد. ۲. فعالیت‌ها: نظارت از جواب: راپور ماهوار - Coordinator ولایت دایکندی - ماه حمل ۱۴۰۵: ۱. مقدمه:

مشکل	اقدام	مسئول	زمان
Stock Card	پیگیری + آموزش	Coordinator	۱۰ ثور
HMIS دیر	آموزش کارمند	HMIS Officer	۱۵ ثور

آزمون آزمایشی ۳

بخش الف: ۱۰ – MCQ سؤال

۱. EPHS چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

الف) خدمات صحت اولیه

• ب) خدمات شفاخانه‌ای

• ج) خدمات قریه

• د) خدمات واکسین

جواب: ب

۲. PPHD چیست؟

الف) Provincial Public Health Directorate

• ب) Public Private Health Department

• ج) Primary Public Health Division

• د) Provincial Primary Health Directorate

جواب: الف

۳. AMC یک دوا ۳۰۰ دانه است؛ موجودی ۶۰۰ دانه. برای چند ماه کافی است؟

الف) ۱ ماه

• ب) ۲ ماه

• ج) ۳ ماه

• د) ۴ ماه

جواب: ب

۴. Supporting Documents شامل کدام است؟

الف) فقط فاکتور

• ب) فاکتور، رسید، قرارداد

• ج) فقط راپور

• د) فقط ایمیل

جواب: ب

۵. SO در کدام ولایت فعال نیست؟

الف) دایکندی

• ب) بامیان

• ج) هرات

• د) غزنی

جواب: ج

۶. اصل دوم چیست؟ PSEA

الف) عدم تحمل مطلق

• ب) ممنوعیت روابط با افراد زیر ۱۸ سال

• ج) گزارش الزامی

• د) محرمیت

جواب: ب

۷. H.MIS به کجا فرستاده می‌شود؟

الف) فقط دفتر مرکزی

• ب) PPHD/NGO - بعد مرکز

• ج) فقط جامعه

• د) فقط شفاخانه

جواب: ب

۸. Reorder Point چیست؟ چه می‌کند؟ ۸۰۰ دانه. یک دوا ۹۰۰ دانه است؛ موجودی ۸۰۰ دانه. چه می‌کند؟

الف) هیچ

• ب) فوراً سفارش بده

• ج) منتظر بمان

• د) به PPHD اطلاع بده

جواب: ب

۹. چقدر طول دارد؟ Executive Summary

الف) ۵ صفحه

• ب) ۳ صفحه

• ج) نصف صفحه

• د) ۱۰ صفحه

جواب: ج

۱۰. چطور رفتار می‌کند؟ PPHD در جلسه Coordinator

الف) خاموش می‌نشیند

• ب) مشکل را واضح می‌گوید + راه حل پیشنهاد می‌کند

• ج) فقط گوش می‌دهد

• د) جلسه را ترک می‌کند

جواب: ب

بخش ب: سؤالات کوتاه - ۵ سؤال

۱. Physical Count چیست؟

جواب: شمردن فیزیکی موجودی دوا.

۲. Advance Clearance چیست؟

جواب: تصفیه Advance با اسناد حمایتی.

۳. Incident Report شامل چه بخش‌هایی است؟

جواب: تاریخ، مکان، شرح، افراد متأثر، اقدام فوری، اقدام بعدی.

۴. PSEA اصل پنجم چیست؟

جواب: گزارش الزامی هر نوع ادعا/شکایت، سوء ظن یا خطر.

۵. Winterization چیست؟

جواب: آمادگی قبل از زمستان برای رساندن دوا به مراکز دورافتاده.

بخش ج: سناریو - ۱ سؤال

تمرین کوتاه

تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. یک کارمند متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده. چه می‌کنی؟

جواب مدل

می‌شود؛ تحقیق محرم انجام می‌شود؛ مطابق پالیسی اقدام می‌شود؛ هیچ تصمیمی بدون تحقیق گرفته نمی‌شود. مرکزی و مسئول PSEA اطلاع می‌دهم؛ کارمند موقتاً از کار کنار گذاشته می‌شود؛ مریض حمایت روانی و صحت محرمیت حفظ می‌کنم؛ فوراً به دفتر

Sample Answer

I would maintain confidentiality, immediately report to the central office and PSEA focal point, suspend the employee pending investigation, ensure the survivor receives support, and follow policy for investigation and action.

بخش د: مصاحبه - ۵ سؤال

۱. خودت را معرفی کن.

شفافیت و پاسخگویی باور دارم و می‌خواهم در SO به عنوان Coordinator ولایتی دایکندی خدمت کنم. [سابقه کاری] کار کرده‌ام و با HMIS، نظارت، تدارکات و هماهنگی با PPHD آشنا هستم. من به کار تیمی، جواب: «نام من [نام] است. من [تحصیلات] دارم و [چند] سال تجربه در بخش صحت دارم. من در

Sample Answer

My name is [Name]. I have a degree in [field] and [X] years of experience in the health sector. I have worked in [previous roles] and I am familiar with HMIS, monitoring, procurement, and coordination with PPHD. I believe in teamwork, transparency, and accountability, and I am eager to serve as Provincial Coordinator for SO in Daikundi.

۲. چرا می‌خواهی در SO کار کنی؟

دارم. می‌خواهم در دایکندی به مردم خدمت کنم و بخشی از تیمی باشم که برای فردای بهتر کار می‌کند. زنان تمرکز دارد. من به مأموریت و ارزش‌های SO - شفافیت، پاسخگویی و حساسیت جنسیتی - باور جواب: «SO در ۱۹۸۹ تأسیس شده و بر صحت، آموزش و توانمندسازی

Sample Answer

SO was founded in 1989 with a focus on health, education, and women's empowerment. I believe in SO's mission and values - transparency, accountability, and gender sensitivity. I want to serve the people of Daikundi and be part of a team working for a better tomorrow.

۳. اگر یک مشکل بزرگ پیش بیاید، چه می‌کنی؟

مربوط اطلاع می‌دهم؛ مستند می‌کنم؛ به دفتر مرکزی و PPHD راپور می‌دهم؛ پیگیری می‌کنم تا حل شود. «اول مشکل را بررسی می‌کنم؛ با منبع اصلی چک می‌کنم؛ اگر فوری است، اقدام فوری می‌کنم؛ به مسئول جواب:

Sample Answer

First, I would verify the issue. I would check against the source. If urgent, I would take immediate action. I would inform the relevant person, document it, report to the central office and PPHD, and follow up until resolved.

۴. چطور با تیم کار می‌کنی؟

می‌کنم. اگر مشکلی باشد، با هم حل می‌کنیم. من از تجربه تیم یاد می‌گیرم و تجربه‌ام را شریک می‌کنم. کار تیمی باور دارم. هر کارمند مسئولیت مشخص دارد. من هماهنگ می‌کنم، راهنمایی می‌دهم و پیگیری جواب: «من به

Sample Answer

I believe in teamwork. Each staff member has clear responsibilities. I coordinate, guide, and follow up. If there is a problem, we solve it together. I learn from the team and share my experience.

۵. چطور PSEA را رعایت می‌کنی؟

محیط امن برای کارمندان و مریضان ایجاد می‌کنم. اگر چیزی ببینم یا بشنوم، فوراً گزارش می‌دهم. مطلق در برابر رفتار نادرست، گزارش الزامی، محرمانه، حمایت از قربانی. من به عنوان Coordinator،

جواب: «من اصول PSEA را می‌دانم: عدم تحمل

Sample Answer

I know the PSEA principles: zero tolerance, mandatory reporting, confidentiality, and survivor support. As Coordinator, I create a safe environment for staff and patients. If I see or hear anything, I report immediately.

۱۰.۱ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- آزمون آزمایشی ۱: MCQ + کوتاه + سناریو + محاسبه.
- آزمون آزمایشی ۲: MCQ + کوتاه + سناریو + راپور.
- آزمون آزمایشی ۳: MCQ + کوتاه + سناریو + مصاحبه.
- در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار ببر.
- در مصاحبه، خودت را معرفی کن، از SO بگو، از تجربیات بگو.
- خط سرخ؛ هیچ استثنایی نیست = PSEA

پیگیری کن ← راپور بده ← مستند کن ← اقدام کن ← اولویت بده ← بررسی کن ← هفت کلمه طلایی: بفهم

جواب‌های طلایی فصل دهم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
خودت را معرفی کن	تجربه، مهارت‌ها، باور به کار تیمی، نام، تحصیلات،	Name, education, experience, skills, belief in teamwork.
چرا SO؟	ارزش‌ها، خدمت به مردم دایکندی، مأموریت،	Mission, values, service to Daikundi people.
اگر مشکل بزرگ پیش بیاید؟	کن، مستند کن، راپور بده، پیگیری کن، بررسی کن، اقدام	Verify, act, document, report, and follow up.
چطور با تیم کار می‌کنی؟	راهنمایی، پیگیری، حل مشکل با هم، هماهنگی،	Coordinate, guide, follow up, and solve problems together.
چطور رعایت می‌کنی؟ PSEA	تحمل مطلق + گزارش الزامی + محرمانه + عدم	Zero tolerance + mandatory reporting + confidentiality.
می‌کند؟ PPHD در جلسه Coordinator چطور رفتار	واضح می‌گوید + راه‌حل پیشنهاد می‌کند مشکل را	Clearly presents the issue and proposes solutions.

نکته آخر فصل دهم

را تمرین کن؛ اگر این‌ها را بلد باشی، برای امتحان واقعی آماده‌ای. هفت کلمه طلایی را در هر جواب به کار ببر. این سه آزمون آزمایشی

پایان کتاب – پیام آخر

کسی است که فکر می‌کند، تصمیم می‌گیرد و پیگیری می‌کند Provincial Coordinator

اگر فقط معلومات جمع کنی و بفرستی، منشی هستی.

اگر فکر کنی، اولویت بدهی، اقدام کنی و پیگیری کنی – Coordinator هستی.

بفهم (Understand)

بررسی کن (Verify)

اولویت بده (Prioritize)

اقدام کن (Act)

مستند کن (Document)

راپور بده (Report)

پیگیری کن (Follow Up)

موفق باشی!

Working for a better tomorrow

پیوست ۱: واژه‌نامه دری-انگلیسی

نشان می‌دهد کدام شکل‌ها (معمولاً ایرانی یا ترجمه ماشینی) در این کتاب به کار نرفته است. می‌نویسی، همین شکل‌ها را استفاده کن تا نوشته‌ات یکدست بماند. ستون «شکل نادرست/غیرمرجح» هر اصطلاح یک بار اینجا تصویب شده و در همه فصل‌ها همان شکل به کار رفته است. وقتی راپور یا ایمیل این واژه‌نامه معیار اصطلاحات کتاب است:

اصطلاح دری (مرجح)	انگلیسی	اختصار	شکل غیرمرجح / توضیح
مراقبت پیش از ولادت	Antenatal Care	ANC	باردار» هم می‌توان اشاره کرد راپور، به ANC یا «معاینه زن «مراقبت بارداری»؛ در
مراقبت بعد از ولادت	Postnatal Care	PNC	—
بخش سرپایی	Out-Patient Department	OPD	در معنی OPD نادرست است «درمانگاه»
مرکز صحتی اساسی	Basic Health Center	BHC	«مرکز بهداشتی» (ایرانی)
مرکز صحتی جامع	Comprehensive Health Center	CHC	—
مرکز صحتی فرعی	Sub Health Center	SHC	—
خانه صحتی / پست صحتی	Health Post	HP	«خانه بهداشت» (ایرانی)
شفاخانه ولسوالی	District Hospital	DH	«شهرستان» (ایرانی) «بیمارستان
شفاخانه ولایتی	Provincial Hospital	PH	«بیمارستان استانی» (ایرانی)
تیم صحتی سیار	Mobile Health Team	MHT	—
کارمند صحتی جامعه (صحیار)	Community Health Worker	CHW	«بهورز» (ایرانی)
قابله	Midwife	—	«ماما» (ایرانی)
شورای صحتی	Health Shura / Health Council	—	«انجمن بهداشت» (ایرانی)
ریاست صحت عامه ولایت	Provincial Public Health Directorate	PPHD	«بهداشت استان» (ایرانی) «اداره
وزارت صحت عامه	Ministry of Public Health	MoPH	«وزارت بهداشت» (ایرانی)
کمیته هماهنگی صحتی ولایت	Provincial Public Health Coordination Committee	PPHCC	—
بسته خدمات صحتی اساسی	Basic Package of Health Services	BPHS	—
خدمات اساسی شفاخانه‌ای بسته	Essential Package of Hospital Services	EPHS	—
معلومات مدیریت صحتی سیستم	Health Management Information System	HMIS	—
ثبت (دفتر ثبت مریضان)	Register	—	(Source Document) منبع اصلی معلومات

اصطلاح دری (مرجع)	انگلیسی	اختصار	شکل غیرمرجع / توضیح
کارت ثبت موجودی	Stock Card	—	در این کتاب به کار نرفته است «کارت انبار»
شمردن فیزیکی موجودی	Physical Count	—	—
مصرف متوسط ماهوار	Average Monthly Consumption	AMC	—
نقطه سفارش مجدد	Reorder Point	—	—
ذخیره احتیاطی	Safety Stock	—	«ذخیره امنیتی»
کمبود دوا	Stock-out	—	«فقدان دارو»
تاریخ انقضا	Expiry Date	—	«تاریخ مصرف» مبهم است «تاریخ انقضاً»؛
زنجیره سرد	Cold Chain	—	—
زمستانی‌سازی	Winterization	—	—
تدارکات	Procurement / Logistics	—	—
درخواست خرید	Purchase Requisition	PR	«درخواست خریداری»
دارایی‌ها	Assets	—	—
ثبت دارایی	Asset Register	—	—
بودجه	Budget	—	—
تفاوت بودجه	Variance	—	—
پیش‌پرداخت	Advance	—	—
تصفیه پیش‌پرداخت	Advance Clearance	—	«تسویه» (ایرانی)
اسناد حمایتی	Supporting Documents	—	«مستندات» در این معنی
پول نقد	Cash	—	—
حسابرسی	Audit	—	«ممیزی» (ایرانی)
شرح وظایف	Terms of Reference	ToR	مرجع «ترجمه لفظی است «شرایط»
اعلان وظیفه	Vacancy Announcement	VA	«آگهی استخدام» (ایرانی)
لیست کوتاه	Shortlisting	—	—
حاضری	Attendance	—	«حضور و غیاب» (ایرانی)
رخصتی	Leave	—	«مرخصی» (ایرانی)
رخصتی زایمان	Maternity Leave	—	—
ارزیابی عملکرد	Performance Evaluation	—	—
روند اجراات	Disciplinary Process	—	«تخلفات اداری» در این معنی
محرمیت	Confidentiality	—	«محرمانگی» (ایرانی)
اجرائیه	Executive Board	—	—
شورای عالی صحت عامه	High Council of Public Health	—	—

اصطلاح دری (مرجع)	انگلیسی	اختصار	شکل غیرمرجع / توضیح
Stakeholder	Stakeholder	—	یا «شریک/طرف مربوط» متن دری، همان Stakeholder (ترجمه لفظی) - در «ذی‌نفعان»
Service Provider	Service Provider	SP	تطبیق‌کننده» در متن این کتاب «سازمان
راپور ماهوار	Monthly Report	—	«گزارش ماهانه» (ایرانی)
راپور ربعوار	Quarterly Report	—	«گزارش فصلی» (ایرانی)
راپور روایتی	Narrative Report	—	—
خلاصه اجرایی	Executive Summary	—	—
پلان اقدام	Action Plan	—	«برنامه عملیاتی» (ایرانی)
راپور حادثه‌ای	Incident Report	—	—
شاخص کلیدی عملکرد	Key Performance Indicator	KPI	—
خطر	Risk	—	که ممکن است اتفاق بیفتد چیزی
مشکل	Issue	—	چیزی که قبلاً اتفاق افتاده
تشدید / بالا بردن مشکل	Escalation	—	—
نظارت	Monitoring	—	در جریان کار
ارزیابی	Evaluation	—	بعد از تمام شدن کار
پیگیری	Follow-up	—	—
اولویت‌بندی	Prioritization	—	—
استثمار و سوء استفاده جنسی حفاظت از	Protection from Sexual Exploitation and Abuse	PSEA	—
گزارش الزامی	Mandatory Reporting	—	—
عدم تحمل مطلق	Zero Tolerance	—	—
شفافیت	Transparency	—	—
پاسخگویی	Accountability	—	—
حساسیت جنسیتی	Gender Sensitivity	—	—
توانمندسازی زنان	Women Economic Empowerment	WEE	—

>● حفظ کن

امروز «مرکز صحنی اساسی» نوشتی و فردا «کلینیک اساسی»، خواننده فکر می‌کند دو چیز متفاوت است.
< در راپور و ایمیل رسمی، یک اصطلاح را همیشه به یک شکل بنویس. اگر

پیوست ۲: قالب‌های کاری و چک‌لیست‌ها

در فصل‌های این کتاب تعلیم داده شده - پس اگر قالب را پر می‌کنی، در واقع روش کار را به کار می‌بری. این پیوست را می‌توانی چاپ کنی و در فایل کاری خود نگه داری. هر قالب، همان چیزی است که

۲.۱ چک‌لیست نظارت از یک مرکز صحت (Monitoring Visit)

پیش از سفر:

- تاریخ و هدف نظارت را در پلان ماهوار خود ثبت کن و به مسئول کلینیک از قبل اطلاع بده.
- راپور ماه گذشته همان کلینیک (HMIS) را بخوان؛ اعداد مشکوک را یادداشت کن.
- چک‌لیست شاخص‌های مورد نظر خودت را آماده کن (حداقل ۱۰ شاخص).
- وسایل کار: چک‌لیست چاپ‌شده، قلم، دفتر، وسایل حفاظتی در صورت ضرورت.

در جریان نظارت:

بخش	چه چیز را چک می‌کنی؟	منبع
ثبت معلومات	ها (ANC، OPD، ولادت، TB، واکسین) کامل‌بودن Register	دفتر ثبت
دوا	فیزیکی، زنجیره سرد، Stock Card تاریخ انقضا، موجودی	و یخچال Stock Card
کارمندان	پرسونل کلیدی (قابله، واکسیناتور) حاضری، موجودیت	برگه حاضری
خدمات	اساسی، ساعت کاری، نظافت و ترتیب ارائه خدمات	مشاهده مستقیم
مریضان	محرمیت، رضایت مریض، شکایات احترام،	گفتگو با مریضان
مرجع	موجودیت سیستم ارجاع و ثبت ارجاع‌ها	دفتر ارجاع
HMIS	تطابق راپور ماه گذشته با Register	راپور و دفتر ثبت

بعد از نظارت (همان روز):

- با مسئول کلینیک جلسه کوتاه بگیر: یافته‌ها، اقدام لازم، مسئول، مهلت.
- پلان اقدام را در راپور نظارت بنویس (مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص).
- راپور نظارت را به PPHD و دفتر مرکزی بفرست.
- تاریخ پیگیری بعدی را در پلان کاری خودت ثبت کن.

۲.۲ قالب راپور ماهوار

راپور ماهوار - دفتر ولایتی [نام ولایت] - ماه [نام ماه] ۱۴۰۵

۱. مقدمه (۲-۳ سطر): این راپور فعالیت‌های صحتی ولایت ... را در ماه ... پوشش می‌دهد.

۲. فعالیت‌های انجام‌شده: (جلسه)؛ جمع‌آوری راپور HMIS از ... مرکز؛ پیگیری تدارکات برای ... مرکز.

نظارت از ... مرکز؛ جلسات با PPHD

۳. نتایج و شاخص‌ها (جدول):

شاخص	این ماه	ماه قبل	تغییر
HMIS Reporting Rate			
Drug Availability			
Supervised facilities			
Attendance Rate			

۴. مشکلات و علت آن‌ها: هر مشکل یک سطر علت بنویس (تخنيکی، نبود کارمند، امنیتی، تأخیر تدارکات).

برای

۵. درس‌های آموخته‌شده: یک یا دو درس عملی که ماه بعد به کار می‌گیری.

۶. پلان ماه آینده: فعالیت، مسئول، زمان.

۷. پلان اقدام:

مشکل	اقدام	مسئول	زمان	شاخص موفقیت
------	-------	-------	------	-------------

۸. ضمیمه‌ها: راپور HMIS، راپور نظارت، جدول حاضری (اگر جداگانه فرستاده نمی‌شود).

۲.۳ قالب راپور حادثه‌ای (Incident Report)

بخش	چیزی که باید بنویسی
تاریخ و وقت دقیق	روز، ساعت، شمسی و میلادی
مکان	ولایت، ولسوالی، مرکز صحتی، محل دقیق
نوع حادثه	آتش‌سوزی، دزدی، مرگ کارمند، تخلف PSEA، رویداد طبیعی امنیتی، صحتی،
شرح حادثه	افتاد، چطور، چه کسی حاضر بود - بدون حدس و بدون قضاوت چه اتفاق
افراد متأثر	مریضان، کارمندان، تیم؛ وضعیت صحتی آن‌ها
اقدام فوری	چه کار کردی، در چه وقت، با کی
اطلاعات به کی داده شد	(دفتر مرکزی، مقامات محلی (با ذکر وقت PPHD،
اقدام بعدی	پلان، مسئول، زمان
ضمیمه‌ها	عکس، راپور صحتی، اظهارات (اگر موجود باشد)

➤ حفظ کن

بفرست و بنویس «معلومات تکمیلی بعداً فرستاده می‌شود». خاموش ماندن، خطرناک‌ترین انتخاب است. حادثه‌ای همان روز فرستاده می‌شود. اگر معلومات کامل نیست، راپور اولیه را با همان معلومات موجود < راپور

۲.۴ کاربرد محاسبه AMC و Reorder Point

ماه	مصرف یک دوا (دانه/بوتل)
ماه اول	
ماه دوم	
ماه سوم	
مجموع سه ماه	
(مجموع ۳ AMC)	
زمان تحویل (ماه)	
ذخیره احتیاطی (ماه)	
Reorder Point = (AMC × زمان تحویل) + (AMC × ذخیره احتیاطی)	
موجودی فعلی	
اقدام	اگر موجودی $\geq$ Reorder Point → سفارش فوری

۲.۵ چک لیست تصفیه پیش پرداخت (Advance Clearance)

- درخواست پیش پرداخت با مبلغ و هدف فعالیت – تایید شده.
- فاکتور یا رسید خرید (به نام سازمان، با تاریخ و شماره).
- برگه حضری یا لیست اشتراک کنندگان (اگر برنامه آموزشی/جلسه بوده).
- راپور فعالیت یا راپور سفر (اگر مربوط به نظارت بوده).
- جدول مصرف: مبلغ اخذ شده، مبلغ مصرف شده، باقی مانده.
- باقی مانده پول: برگشت به صندوق یا ثبت در سند رسمی.
- امضای مسئول مالی و Coordinator.
- ثبت در سیستم مالی و نگهداری کپی در فایل فعالیت.

۲.۶ قالب پلان کاری ماهوار

هفته	فعالیت	مسئول	ساحه / وسیله	تاریخ	شاخص تطبیق
۱					
۲					
۳					
۴					

۲.۷ قالب صورت جلسه کوتاه (Minutes)

- تاریخ، وقت، مکان؛ اشتراک کنندگان (نام و وظیفه).
- اجندا (۳-۵ نقطه).
- تصمیم ها: هر تصمیم با مسئول و مهلت.
- مطالبات از سازمان تو و از PPHD (جدا جدا).

• تاریخ جلسه بعدی و تاریخ فرستادن صورت جلسه.

پیوست ۳: پلان ۹۰ روزه اول کار

اگر تازه به این بست گماشته شده‌ای، این پلان را روی دیوار دفتر خود بچسبان.

روزهای ۱-۳۰: بفهم

- وظیفه: اسناد، راپورها، Stock Card ها، فایل‌های HR، اسناد مالی، فهرست مراکز صحتی زیر پوشش.
 - ملاقات با Coordinator قبلی و تحویل‌گیری
 - معرفی رسمی به PPHD ولایت و گرفتن فهرست نقاط تماس.
 - جلسه با تیم ولایتی: چه کسی چه کار می‌کند، کدام مشکل فوری است.
 - خواندن راپورهای سه ماه گذشته: کدام شاخص ضعیف است؟
 - بازدید از دو مرکز صحتی نزدیک برای شناخت واقعیت ساحه.
 - تهیه فهرست مشکلات فوری (زندگی مردم، خدمات اساسی) و راپور آن به دفتر مرکزی.
- روزهای ۳۱-۶۰: سازماندهی کن

- پلان کاری ماهوار با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری.
 - یک چرخه کامل نظارت: بازدید، راپور، پلان اقدام، پیگیری.
 - چک کردن وضعیت HMIS: کدام مراکز راپور نمی‌دهند و چرا.
 - چک کردن Stock Card ها و ساختن پلان زمستانی/تدارکاتی برای مراکز دورافتاده.
 - جلسه با شورای صحتی یک قریه و شنیدن مشکلات جامعه.
 - مطمئن شدن از اینکه فایل‌های HR و حاضری منظم اند و مسئول PSEA در ولایت معلوم است.
- روزهای ۶۱-۹۰: نتیجه بده

- یک بهبود قابل اندازه‌گیری نشان بده (مثلاً Reporting Rate از ۸۰٪ به ۹۵٪).
- یک مشکل ساختاری را با PPHD و دفتر مرکزی حل کن (مثلاً کمبود قابله در یک ولسوالی).
- راپور ربعوار را با تحلیل - نه فقط لیست - بنویس.
- بازیابی خودت: کدام سه کار را باید دفعه بعد بهتر انجام بدهی؟

پیوست ۴: راهنمای امتحان و مصاحبه

- ساختار جواب در سناریو (در هر سناریو همین ترتیب):
۱. فوری: آیا جان کسی در خطر است؟ اگر بله، همین را اول بگو.
 ۲. بررسی: معلومات را با منبع اصلی (Register، Stock Card، حاضری) چک می‌کنم.
 ۳. اولویت: کدام کار اول، چرا.
 ۴. اقدام: چه کسی، چه کار، تا کی.
 ۵. مستندسازی و راپور: در راپور نظارت/حادثه‌ای ثبت و به PPHD و دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم.
 ۶. پیگیری: تاریخ پیگیری مشخص می‌کنم و نتیجه را چک می‌کنم.
- جمله‌های کلیدی که امتیاز می‌گیرند:
- «اول جان مریض و تداوم خدمات اساسی؛ بعد راپور و جلسات.»
 - «معلومات را با منبع اصلی مقایسه می‌کنم، نه با راپور قبلی.»
 - «هر مشکل باید اقدام، مسئول، زمان و شاخص داشته باشد.»
 - «در صورت شک در PSEA، محرمیت را حفظ می‌کنم و فوراً از کانال رسمی گزارش می‌دهم.»
 - «اگر از توان من بالاتر بود، Escalate می‌کنم – اما اول خودم تلاش می‌کنم.»
- سؤال‌های متداول مصاحبه (با یک سطر راهنما):

سؤال	راهنمای جواب
خودت را معرفی کن	کاری مرتبط، دو مهارت قوی، علاقه به کار تیمی – در یک دقیقه نام، تحصیلات، تجربه
چرا این بست را می‌خواهی؟	سازمان، ارتباط تجربیات با وظایف بست، خدمت به مردم ولایت مأموریت
یک مشکل را چطور حل کردی؟	یک مثال واقعی با ساختار: موقعیت ← بررسی ← اقدام ← نتیجه ← درس
اگر راپور HMIS ناقص باشد چه می‌کنی؟	علت را پیدا کن، جمع کن، اطلاع بده، پیگیری کن
اگر دوا تمام شود چه می‌کنی؟	فوری حل کن، علت را با Stock Card پیدا کن، پیگیری کن
با PPHD چطور هماهنگ می‌کنی؟	جلسات، راپور منظم، طرح مشکلات با راه‌حل
چيست و چطور رعایت می‌کنی؟ PSEA	شش‌گانه IASC، محرمیت، گزارش فوری، حمایت از قربانی اصول
ضعف خودت چیست؟	یک ضعف واقعی + کاری که برای بهبود آن می‌کنی
چه سؤال‌هایی از ما داری؟	جدی در مورد تیم، شاخص‌های موفقیت بست یا سه ماه اول کار یک سؤال

پیوست ۵: منابع و مراجع

و منابع زیر تهیه و تصحیح شده است. برای راپورها و کار روزمره، نسخه‌های به‌روز همین منابع معیار است. این کتاب بر اساس اسناد

۱. وزارت صحت عامه افغانستان (MoPH) (۱۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰ نفر) و شفاخانه ولایتی (۲۰۰,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۰ نفر). Health Post (نفر)، (۱۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰) BHC (نفر)، (۳۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰) CHC (نفر)، شفاخانه ولسوالی - «بسته خدمات صحتی اساسی (BPHS)»، نسخه ۲۰۱۰: معیار جمعیتی (۱,۰۰۰-۱,۵۰۰)

۲. وزارت صحت عامه افغانستان - قبل از هفتم هر ماه؛ راپور ربعوار - تا پایان ماه اول ربع جدید. روند (HMIS (HMIS Procedures Manual): مهلت فرستادن راپور تلفیقی ماهانه به سازمان/PPHD/سازمان - «رهنمای

۳. وزارت صحت عامه افغانستان و غذا، مالی و اداری) - moph.gov.af، صفحه «General Directories». ساختار وزارت و ریاست‌های عمومی (چهار معینیت: خدمات صحتی، پالیسی و انکشاف، طب

۴. سازمان جهانی صحت (WHO EMRO) صحتی دسترسی داشتند: «Health Systems, Afghanistan» - ۲۰۱۸ در افغانستان ۳,۱۳۵ مرکز صحتی فعال بود و نزدیک به ۸۷٪ مردم در فاصله دو ساعته به خدمات در سال.

۵. ASC۵ (۲۰۰۲) «Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse» - در فصل ششم PSEA با بازبینی‌های بعدی):

۶. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد (UNICEF) همکاری Service Provider ها و نظارت MoPH و PPHD. مدیریت قراردادهای BPHS/EPHS از سوی UNICEF (خدمات صحت اولیه) و WHO (خدمات شفاخانه‌ای) با - ارزیابی برنامه «Health Emergency Response / Novel Financing Arrangement»:

۷. گزارش‌های وضعیت صحتی افغانستان (۲۰۲۴-۲۰۲۵) و تمديد کمک‌های صحتی عامه تا پایان ۲۰۲۶. - کاهش تعداد مراکز صحتی فعال پس از

۸. Shuhada Organization فعالیت در صحت، آموزش و توانمندسازی زنان در ولایات مرکزی افغانستان). - تاریخچه، مأموریت و گزارش‌های سالانه سازمان (تأسیس ۱۹۸۹ در کوئته، پاکستان؛

● حفظ کن

و کدام دوره است - مثلاً «منبع: Register کلینیک، ماه حمل ۱۴۰۵». راپور بدون منبع، قابل دفاع نیست. < در راپور رسمی، همیشه بنویس که معلومات از کدام منبع

درباره این نسخه

نام کتاب: قانون زبان – راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

ناشر/تهیه‌کننده: دفتر ولایتی دایکندی – Shuhada Organization

نسخه: دوم – ویرایش‌شده، تصحیح‌شده و آماده نشر

سال: ۱۴۰۵ خورشیدی

زبان: دری (افغانی) با اصطلاحات انگلیسی در متن

سلسله نسخه‌ها: نسخه اصلی دریافت‌شده ← نسخه کاری ← نسخه تصحیح‌شده علمی ← زبانی
نسخه ویرایش‌شده ← تولید (PDF، DOCX و EPUB). نسخه اصلی هرگز تغییر نکرده و نگهداری می‌شود.
نسخه نهایی (منبع)

روش ویرایش این نسخه: جدید اضافه شد. تمام تصحیحات در «لاگ تغییرات ویرایشی» ثبت شده است.
«اهداف این فصل» اضافه شد؛ بخش ۳.۸ (نظام صحتی امروز)، پیوست‌های کاری، واژه‌نامه و فهرست منابع
و تصحیح شد؛ اصطلاحات افغانی یکدست شد؛ نیم‌فاصله، نقطه‌گذاری و اعداد نظم گرفت؛ به هر فصل
ساختار کتاب بازبینی شد؛ معیارهای صحتی و اداری با منابع معتبر مقایسه

پیشنهاد و اصلاح: شود. شکل درست اصلاح: شماره فصل و بخش، متن فعلی، متن پیشنهادی، و منبع.
تفاوت داشت، آن را از راه دفتر ولایتی Shuhada Organization اطلاع بده تا در نسخه بعدی اصلاح
زنده است. اگر در کار خود به معلومات تازه‌تری رسیدی، یا جایی از کتاب با دستور رسمی PPHD/MoPH
این کتاب یک سند

یادآوری: و اداری، راهنمای رسمی وزارت صحت عامه، پالیسی سازمان و هدایت PPHD معیار نهایی است.
این کتاب راهنمای آموزشی است. در تصمیم‌های کلینیکی